NTS N° 220-MINSA-DGIESP-2024

NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Resolución Ministerial N° 884-2024-MINSA



Gobierno del Perú

PERÚ | Ministerio de Salud

NTS N° 220-MINSA-DGIESP-2024

NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Resolución Ministerial N° 884-2024-MINSA

Catalogación hecha por la Biblioteca del Ministerio de Salud

NTS N° 220-MINSA- DGIESP-2024. norma técnica de salud que establece el procedimiento de evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional de los trabajadores asegurados al seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). R.M. N° 884-2024-MINSA / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas. Lima: Ministerio de Salud; 2026.
99 p. ilus.
ACCIDENTES DE TRABAJO / AUSENCIA POR ENFERMEDAD / RIESGOS LABORALES / MEDICOS LABORALES / ESTUDIO DE EVALUACIÓN

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2026-11545

NTS N° 220-MINSA- DGIESP-2024. Norma Técnica de Salud que establece el Procedimiento de Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional de los Trabajadores asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). R.M. N° 884-2024-MINSA.

Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas.

(MINSA / DGIESP / DENOT).

Equipo de Trabajo:
M.C. Yoan Neltons Mayta Paulet, MINSA / DGIESP/ DENOT
M.C. Julio César Castillo Fernández, MINSA / DGIESP/ DENOT
M.C. José Fernando Madariaga Pérez, MINSA / DGIESP/ DENOT
M.C. Salvador Ramón Zelaya Medina, MINSA / DGIESP/ DENOT
M.C. Fiorella Verenice Mendo Caceres, MINSA / DGIESP/ DENOT
M.C. Clara Milagros Herrera Puma, MINSA / DGIESP /DENOT
M. C. Mary Karla Ochoa Hernandez, MINSA / DGIESP / DENOT
Lic. Enf. Bety Lope Bernuy, MINSA / DGIESP/ DENOT
Lic. Asist. Social Margot Sánchez Mocilote, MINSA / DGIESP/ DENOT
Lic. Obst. María del Rosario Mejía Andrade, MINSA / DGIESP/ DENOT
Tec. Dany Gil Cuzco, MINSA / DGIESP/ DENOT
Asist. Tec. Jenny Diana López Echegaray, MINSA / DGIESP/ DENOT

Colaboradores:
M.C. Jorge Luis Hudtwalcker Morán, International SOS
M.C: José Jesús Francia Romero, Miembro de la SOMOMA / CMP

Diseño y Diagramación:
Tec. Dany Gil Cuzco, MINSA / DGIESP/ DENOT

© MINSA, Setiembre 2026
Ministerio de Salud.

Av. Salaverry N° 801, Lima 11, Perú
Teléfono: (51-1) 315- 6600
www.gob.pe/minsa
webmaster@minsa.gob.pe

1era Edición, Setiembre 2026
Versión digital disponible:
https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/8003.pdf

LUIS WILLIAMS DAYER FERNANDEZ
Ministro de Salud

MARÍA SOFÍA CUBA FUENTES
Viceministro de Salud Pública

CARLOS ALBERTO ESPINOZA BARRETO
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

JUAN CARLOS GONZALES HIDALGO
Secretario General

WILDER VIDAURO CARPIO MONTENEGRO
Director General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

PERCY ALBERTO HERRERA AÑAZCO
Director Ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas

Tabla de contenido Pág.

RESOLUCION MINISTERIAL.....8
I. FINALIDAD 12
II. OBJETIVOS 12
2.1 Objetivo Principal 12
2.2 Objetivos Específicos 12
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 12
IV. BASE LEGAL 12
Leyes 12
Decretos Legislativos 13
Decretos Supremos 13
Reglamentos 13
Resoluciones Ministeriales 13
Resoluciones Jefaturales 13
Resoluciones Secretariales 14
V. DISPOSICIONES GENERALES 14
5.1 Definiciones Operativas 14
5.2 Abreviaturas 24
5.3 La evaluación de la incapacidad laboral por AT o EP 25
5.4 La calificación y certificación de la incapacidad laboral por AT o EP.....25
5.5 La condición de incapacidad laboral por AT o EP 26
5.6 El expediente médico 26
5.7 La aseguradora del SCTR.....26
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 27
6.1 De la solicitud para la evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional.....27
6.1.1. Inicio de la solicitud 27
6.1.2 Remisión de documentos.....27
6.1.3 Solicitud del empleador.....27
6.1.4 Plazo del empleador 27
6.1.5 Incumplimiento del plazo.....27
6.1.6 Presentación al ES evaluador 27
6.1.7 Presentación por persona de apoyo.....27
6.1.8 Evaluación en el ES más cercano.....27
6.1.9 Cobertura de costos.....28

6.2 De la evaluación médica de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional....28
6.2.1 Especialidades y equipamiento....28
6.2.2 Requisitos del Establecimiento de Salud evaluador....30
6.2.3 Subetapas de la EM de la incapacidad laboral por AT o EP....30
6.2.3.1 Subetapa 1: Diagnóstico y Reconocimiento de la Enfermedad Profesional o Accidente de Trabajo....30
6.2.3.2 Subetapa 2: Evaluación Médica de las Deficiencias....36
6.2.3.3 Subetapa 3: Evaluación y Análisis del Rol Laboral....38
6.2.3.4 Subetapa 4: Evaluación de la Restricción en la Participación....47
6.3 De La Conformación de las Comisiones Calificadoras de Incapacidad Laboral Por Accidente De Trabajo o Enfermedad Profesional....51
6.4 De La Calificación de la Incapacidad Laboral Por Accidente De Trabajo o Enfermedad Profesional....59
6.5 De La Certificación Y Entrega Del Certificado De Incapacidad Laboral Por Accidente De Trabajo O Enfermedad Profesional....66
6.6 Del Sistema de Registro de Información Para La Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral Por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional....67
VII. RESPONSABILIDADES....68
7.1 NIVEL NACIONAL....68
7.2 NIVEL REGIONAL....68
7.3 NIVEL LOCAL....68
VIII. DISPOSICIONES FINALES....68
IX. ANEXOS....70
X. BIBLIOGRAFÍA....97

MINISTERIO DE SALUD

No. 884-2024/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 17 de DICIEMBRE del 2024

VISTO; el Expediente N° DGIESP-DENOT20240001003, que contiene el Memorándum N° D005848-2024-DGIESP-MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que remite la Nota Informativa N° D001548-2024-DGIESP-DENOT-MINSA y el Informe N°D000078-2024-DGIESP-DENOT-MSM-MINSA, de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas; y el Informe N° D001168-2024-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece en su Primera Disposición Complementaria Final, modificada por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo establece la Ley N° 26842, Ley General de Salud, tiene a su cargo la función rectora a nivel nacional, la formulación, dirección y gestión de la política nacional de salud y es la máxima autoridad rectora en el sector;

Que, el numeral 4-A del citado Decreto Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades, establece que, la potestad rectora del Ministerio de Salud comprende la facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar y, cuando corresponda, sancionar, en los ámbitos que comprenden la materia de salud. La rectoría en materia de salud dentro del sector la ejerce el Ministerio de Salud por cuenta propia o, por delegación expresa, a través de sus organismos públicos adscritos y, dentro del marco y los límites establecidos en la citada Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial y las normas que rigen el proceso de descentralización;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del referido Decreto Legislativo N° 1161, establecen como funciones rectoras del Ministerio de Salud, las de formular, planear, dirigir,

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles del gobierno; y, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, la gestión de los recursos del sector; así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias de su competencia;

Que, el artículo 19 de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto Supremo o norma con rango de ley, siendo obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora;

Que, los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley N° 26790, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, establecen que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo comprende las siguientes coberturas: a) La cobertura de salud por trabajo de riesgo y; b) la cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo;

Que, el Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, establece en su artículo 30 que, mediante Resolución Ministerial, el Ministerio de Salud designará una Comisión Técnica Médica encargada de proponer al Ministerio de Salud, previa coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación, las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores asegurados a que deben sujetarse las Aseguradoras y el Instituto Nacional de Rehabilitación;

Que, en el marco del artículo 30 de las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, mediante Resolución Ministerial N° 761-2022/MINSA, de fecha 23 de setiembre de 2022, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Salud, denominado "Comisión Técnica Médica", con el objeto de proponer, previa coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación, las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR);

Que, asimismo, mediante Sentencia 313/2023 de fecha 6 de junio de 2023, recaída en el Expediente N° 05124-2022-PA/TC, el Pleno del Tribunal Constitucional, ordena al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud cumplir con lo dispuesto en la Sentencia 00799-2014-PA/TC, en el extremo referido a *"implementar comisiones médicas calificadoras de incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad profesional en sus principales establecimientos de salud, a nivel nacional, que cumplan los estándares nacionales e internacionales"*;

Que, el literal b) del artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA y modificatorias, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública tiene por función, proponer e implementar, en lo que corresponda, políticas, normas y otros documentos normativos en materia de intervenciones estratégicas de Salud Pública;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 775-2024-MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 8 de noviembre de 2024, se efectuó la publicación del proyecto de Norma Técnica de Salud que establece el procedimiento de evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional de los trabajadores asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), formulada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a partir

MINISTERIO DE SALUD

No. 884-2024/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 17 de DICIEMBRE del 2024

de la propuesta remitida por la Comisión Técnica Médica conformada mediante Resolución Ministerial N° 761-2022/MINSA;

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, informa sobre los comentarios recibidos respecto a la mencionada norma técnica, en ese sentido, en el marco de sus competencias, formula y sustenta la aprobación de la Norma Técnica de Salud que establece el procedimiento de evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional de los trabajadores asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR); asimismo, en atención a la aprobación de la referida norma técnica, la citada Dirección General señala que, corresponde derogar el Documento Técnico: "Evaluación y Calificación de la Invalidez por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales", aprobado con Resolución Ministerial N° 069-2011/MINSA;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaría General y del Despacho Viceministerial de Salud Pública; y;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 220 -MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud que establece el procedimiento de evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional de los trabajadores asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), que como Anexo

forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial y se publica en la sede digital del Ministerio de Salud.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 069-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Evaluación y Calificación de la Invalidez por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales".

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

I. FINALIDAD

Contribuir a la protección del bienestar del trabajador asegurado al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, determinando la existencia o no de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional y el grado de la misma.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Principal

Establecer el procedimiento de Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional de los trabajadores asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), requerida para el otorgamiento de la cobertura de invalidez que brinda el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

2.2 Objetivos Específicos

- Establecer las disposiciones para la evaluación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- Establecer los criterios para la calificación y certificación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- Establecer los criterios de conformación y funcionamiento de las Comisiones Médicas Calificadoras de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de alcance nacional y de aplicación obligatoria en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud-EsSalud, de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de salud de las Entidades Prestadoras de Salud privadas; a partir del nivel de categorización II-2.

Asimismo, será de aplicación a todos los empleadores y aseguradoras públicas y privadas que participan en el proceso de la determinación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores con derecho a cobertura por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

IV. BASE LEGAL

Leyes

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro.

- Ley N° 31025, Ley que incorpora a la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de salud.

Decretos Legislativos

- Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece el Instituto Nacional de Salud para la Prevención y Control de Enfermedades.

Decretos Supremos

- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
- Decreto Supremo N° 003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 007-2022-SA, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud-INS.
- Decreto Supremo N° 008-2022-SA, Actualización del Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA.
- Decreto Supremo N°016-2023-SA que aprueba la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud – INS Resolución Ministerial Nº480-2008-MINSA, que aprueba la NTS N° 068-MINSA/DGSP-V.1 "Norma Técnica de Salud que establece el listado de Enfermedades Profesionales".

Reglamentos

- Reglamento de la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.

Resoluciones Ministeriales

- Resolución Ministerial N° 308-2009-MINSA, que aprueba la NTS N° 079-MINSA/DGSP-INR-V.01, Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación.
- Resolución Ministerial N° 076-2014-MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la Categorización de los Establecimientos del Sector Salud.
- Resolución Ministerial N° 021-2016-MINSA, que aprueba el perfil de competencias del médico ocupacional debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú.
- Resolución Ministerial N° 214-2018-MINSA, que aprueba la NTS N° 139-MINSA/2018/DGAIN, "Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica".
- Resolución Ministerial N° 653-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Bases Conceptuales para el Ejercicio de la Rectoría Sectorial del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial N° 826-2021-MINSA, que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".

Resoluciones Jefaturales

- Resolución Jefatural N° 167-2023-J-OPE/INS, que aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud.

Resoluciones Secretariales

- Resolución Secretarial Nº076-2024-MINSA que conforma la Unidad Funcional de Salud Ocupacional e Incapacidad Laboral de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, dependiente de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, No Transmisibles, Raras y Huérfanas.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Definiciones Operativas

Término	Definición
Accidente de trabajo	Toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo, con arreglo al Decreto Supremo N°003-98-SA y sus modificaciones.
Accidente Común	Todo accidente que no sea calificado como accidente de trabajo con arreglo a las normas del Decreto Supremo N°003-98-SA, será tratado como accidente común sujeto al régimen general del Seguro Social en Salud y al sistema pensionario al que se encuentre afiliado el trabajador.
Actividades principales	Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con las responsabilidades centrales de un puesto de trabajo. Estas son las tareas clave que deben realizarse para cumplir con los objetivos principales del trabajo. Ejemplos de actividades principales incluyen la producción de bienes, la prestación de servicios esenciales o la toma de decisiones críticas.
Actividades secundarias	Son aquellas actividades que apoyan o complementan las actividades principales. No son el foco principal del trabajo, pero son necesarias para facilitar o mantener el flujo del trabajo principal. Ejemplos de actividades secundarias podrían incluir tareas administrativas, limpieza, mantenimiento de equipos o la organización de herramientas.
Agudeza visual binocular	La agudeza visual (AV) es la capacidad del sistema visual para reconocer la imagen más pequeña a una distancia determinada. Depende de la integridad anátomo-funcional del aparato visual (transparencia de los medios oculares: córnea, cristalino, humor

Término	Definición
	acuoso y vítreo) y funcionabilidad de la retina, específicamente de los conos de la fóvea.
Ambiente térmico	Es la combinación de variables ambientales como temperatura, radiación, humedad e individuales del trabajador.
Ambiente sonoro	Son todos aquellos sonidos que son característicos de un lugar, propios de un momento o de una determinada actividad.
Aptitud física	Capacidad de realizar diariamente tareas con vigor y alerta, sin fatiga excesiva y con amplia energía para disfrutar de actividades de ocio y afrontar emergencias imprevistas.
Asegurado	Es el trabajador asegurado que está expuesto al riesgo y a cuyo favor se hubiese extendido el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo bajo cualquiera de sus coberturas. Para fines de la presente norma técnica de salud también hace referencia al beneficiario por la cobertura supletoria.
Beneficiario por Cobertura Supletoria	Aquel trabajador que realiza labores de alto riesgo señaladas en el Decreto Supremo N° 003-98-SA y que su empleador no haya contratado el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por lo que está dentro del ámbito de protección de la cobertura supletoria prevista en el artículo 88 del Reglamento de la Ley N° 26790 Ley de la Modernización de la Seguridad Social de Salud.
Aseguradora	Es la entidad que brinda la cobertura por prestaciones económicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Lo que incluye a las aseguradoras y a la Oficina de Normalización Provisional (ONP) cuando haya brindado la referida cobertura, sea por haber celebrado un contrato de seguro o por la cobertura supletoria prevista en el artículo 88 del Reglamento de la Ley N° 26790. Ley de la Modernización de la Seguridad Social de Salud.
Audibilidad	Capacidad del paciente para hablar a un nivel suficiente como para ser oído. Se puede catalogar como adecuada o bien no adecuada cuando no logra mantenerse en lugares con ruido leve o no logra ser mantenida en el tiempo.

Término	Definición
Autonomía laboral	Es la libertad que tienen los empleados para controlar aspectos de sus actividades toma de decisiones en sus tareas y flexibilidad de horarios.
Autosuficiencia económica	Independencia y nivel económico que puede tener una persona en relación directa con la repercusión o impacto económico negativo generado por una deficiencia. Incluye la capacidad de la persona para cumplir con el mínimo vital de la persona y su familia.
Bipedestación	Postura en la que el trabajador se encuentra de pie de forma estática o dinámica, excluyendo la marcha por terreno irregular que se valora en el apartado siguiente.
Calificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional	Es el procedimiento técnico-médico y legal mediante el cual se establece la pérdida de la capacidad laboral de una persona relacionada a trabajo habitual y las deficiencias para realizar un trabajo compatible con sus capacidades.
Campo visual	Extensión que percibe el ojo y abarca: 90° por el lado temporal, 60° por el lado nasal y 70° por los lados superior e inferior. Un campo visual que conserve los 30° centrales permite realizar la mayoría de las actividades porque éste es el campo en el que generalmente nos movemos.
Capacidades	Conjunto de cualidades o aptitudes que hacen que la persona pueda ser capaz de desarrollar o ejecutar una tarea.
Capacidad estructural	Son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.
Capacidad funcional	Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones psicológicas).
Carga estática	Es aquella carga constante, que no varía en el transcurso del tiempo. Para considerar que una carga es estática, debe tener magnitud, dirección y ubicación invariables.

Término	Definición
Carga postural	Se refiere a las posiciones de trabajo que dejan de estar en una posición natural (confort) para pasar a una posición forzada.
Carga física de trabajo	Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la persona está expuesta a lo largo de su jornada laboral, y que, de forma independiente o combinada, pueden alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la salud a las personas expuestas.
Carga mental de trabajo	Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo.
Certificado de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional	Documento técnico médico y legal expedido por la Comisión Calificadora de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional que determina el grado y naturaleza de la incapacidad laboral del trabajador asegurado al SCTR.
Clases funcionales	Refleja el estado de salud de la persona al momento de su evaluación médica, se constituye en base a la información brindada por el evaluado, los signos y síntomas, así como los resultados de los exámenes que miden la capacidad funcional y anatómica de un órgano o sistema, agrupándolos por su frecuencia e intensidad de los síntomas, respuesta al tratamiento y repercusión en el desarrollo de su vida cotidiana y laboral.
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)	Constituye el marco conceptual de la OMS para una nueva comprensión del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Es una clasificación universal que establece un marco y lenguaje estandarizados para describir la salud y las dimensiones relacionadas con ella. Abarca tres componentes esenciales: funciones corporales/estructuras, actividad y participación, integrados bajo los términos "funcionamiento" y "discapacidad", que dependen de la condición de salud y de su interacción con factores contextuales.
Comisión Calificadora de Incapacidad Laboral por	Es el equipo técnico multidisciplinario responsable y encargado de valorar el expediente médico y calificar la incapacidad laboral de los asegurados o asegurados por cobertura supletoria del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, a fin de

Término	Definición
Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional	determinar el grado de incapacidad laboral que corresponda, aplicando los instrumentos de calificación de la incapacidad laboral aprobados por el Ministerio de Salud. En adelante citada como Comisión-SCTR.
Coordinación manipulativa	Es el movimiento que implican dar fuerza a objetos o recibir fuerza de objetos.
Control emocional	Es el resultado de la comprensión que una persona hace de sus emociones, pues estas son reacciones fisiológicas ante los estímulos externos que recibimos constantemente.
Conocimiento numérico	Es un grupo de habilidades que permite que se trabaje con números, e incluye: entender cantidades, entender conceptos como más y menos, y mayor o menor, reconocer las relaciones entre elementos y grupos de elementos.
Deficiencia	Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Puede ser temporal o permanente y en principio afecta sólo al órgano.
Dependencia	En términos de ergonomía laboral se interpreta como grado de libertad que tiene el trabajador en su puesto de trabajo para realizar sus tareas.
Determinación de Invalidez	Es el proceso administrativo y legal mediante el cual el órgano competente, la aseguradora o la Oficina de Normalización Previsional-ONP, evalúa la documentación, entre otros el Certificado Médico de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, y determina el otorgamiento de la prestación por incapacidad laboral derivada de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo.
Diagnóstico de Enfermedad	Proceso clínico mediante el cual se identifica una enfermedad en un paciente a través de la evaluación de síntomas, signos, antecedentes médicos y pruebas diagnósticas.
Empleador	Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores.
Enfermedad Común	Toda enfermedad que no sea calificado como accidente de trabajo con arreglo a las normas del Decreto Supremo N°003-

Término	Definición
	98-SA, será tratado como enfermedad común sujeto al régimen general del Seguro Social en Salud y al sistema pensionario al que se encuentre afiliado el trabajador.
Enfermedad Profesional	De acuerdo con lo establecido por el Inciso n) de Artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-97 SA, se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o de medio en que se ha visto obligado a trabajar.
Establecimiento de Salud para la evaluación	Establecimiento de salud público, privado o mixto a partir de nivel de categorización II-2 que realiza la etapa de evaluación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Evaluación Médica de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional	Es el procedimiento médico que tiene por objetivo determinar el diagnóstico de enfermedad profesional o la secuela por accidente de trabajo, así como de evaluar la deficiencia laboral producida por la patología laboral.
Expediente médico	Conjunto de documentos en formato físico y/o magnético que contiene la historia clínica y la historia ocupacional que se conforman para la evaluación, calificación y expedición del Certificado Médico de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.
Grado de Incapacidad laboral	Interpretación de porcentaje de merma en el desarrollo del trabajo habitual de la persona, reconociéndose tres situaciones: Incapacidad parcial, incapacidad total y gran incapacidad.
Gran Incapacidad	Hace referencia a la condición de incapacidad total permanente que además requiera indispensablemente del auxilio de otra persona para movilizarse o para realizar funciones esenciales para la vida.
Higiene ocupacional	Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que

Término	Definición
	puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales.
Incapacidad	Es el producto de una restricción anatómica, fisiológica o psicológica con ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el individuo, de causa laboral o general; demostrable por técnicas adecuadas y evidenciables desde el punto de vista clínico, de exámenes de ayuda al diagnóstico u otros estudios. Puede ser valorada en el tiempo y severidad. Es una contingencia protegida que indica carencia de la capacidad laboral y que se regula por normatividad específica de seguridad social o de sistemas previsionales, y que tiene repercusión económica y laboral.
Incapacidad laboral	Disminución de la posibilidad o pérdida de la capacidad para desarrollar las actividades laborales habituales a consecuencia de una enfermedad profesional o accidente de trabajo.
Incapacidad laboral parcial	Disminución en la capacidad del trabajo en una proporción igual o mayor al 20% de la existente antes de la enfermedad profesional o accidente de trabajo, pero menor a los dos tercios.
Incapacidad laboral permanente	Situación en la cual el trabajador está imposibilitado física o psíquicamente para realizar su trabajo habitual a consecuencia de una enfermedad o accidente, después de haber estado sometido a tratamiento médico, presentando reducciones anatómicas o funcionales previsiblemente definitivas que disminuyen o anulan su capacidad laboral de forma permanente. Esta situación se determina de acuerdo con la evidencia científica y el pronunciamiento médico respectivo, según las disposiciones legales y reglamentarias.
Incapacidad laboral temporal	Pérdida o disminución de la capacidad para desarrollar las actividades laborales habituales a consecuencia de una enfermedad o daño susceptible de ser tratada y recuperada en un periodo determinado de acuerdo a la evidencia científica y al pronunciamiento médico respectivo, según las disposiciones legales y reglamentarias.

Término	Definición
Incapacidad laboral total	Disminución en la capacidad del trabajo en una proporción igual o mayor a los dos tercios de la existente antes de la enfermedad profesional o accidente de trabajo.
Lenguaje expresivo	Es la capacidad de manejar vocabulario y unir palabras en oraciones para expresar su punto de vista.
Lenguaje compresivo	Es la capacidad de las personas para comprender lo que dicen los demás. Es el proceso que implica recibir un mensaje y entender qué es lo que nos están diciendo o indicando.
Manipulación manual de cargas	Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Manipulaciones sencillas	Manipulaciones que no reúnen las condiciones especificadas. Ejemplos: manipulaciones de objetos.
Manipulaciones de complejidad media	Las que se realicen preferentemente sobre objetos pequeños y/o con necesidad de rapidez y/o que precisen habilidad manual, específicamente uso reiterado de pinza fina. Ejemplos: montaje de piezas y cierto tipo de envasados.
Manipulaciones de complejidad elevada	Las que se realicen sobre objetos muy pequeños o de difícil manejo y/o que precisen gran habilidad manual, exactitud o delicadeza elevada, bien por sus características intrínsecas o por sus consecuencias. Ejemplos: intervenciones quirúrgicas; reparación de aparatos electrónicos o de relojería.
Memoria visual	Capacidad que posee la persona para retener la información visual en un tiempo limitado.
Menoscabo de la capacidad laboral	Es el porcentaje producto de una incapacidad, que se determina por una pérdida de la capacidad laboral, ganancial y productiva. El menoscabo de la capacidad laboral es asignado exclusivamente por una Comisión Calificadora de la Incapacidad Laboral, en concordancia con las normas legales vigentes. Refleja el impacto que las deficiencias, el rol laboral y restricción

Término	Definición
	en la participación ocasionan sobre las actividades de la vida diaria y las exigencias del trabajo.
Naturaleza de la incapacidad laboral	Esta referida a determinar el tiempo que dura la carencia de la capacidad laboral, mide el pronóstico y recuperabilidad de esta, pudiendo ser temporal o permanente.
Perfil del puesto de trabajo	Son descripciones concretas de las características, tareas y responsabilidades que tiene un puesto en la organización, así como las competencias y conocimientos que debe tener la persona que lo ocupe.
Orientación espacial	Es la competencia de la persona que involucra establecer diferentes posiciones en el espacio y operar con ellas; incluye la propia posición y sus movimientos.
Organización	Son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos.
Participación	Rol que cumple un individuo al involucrarse en una situación vital, por ejemplo: comunicarse, autocuidado, relaciones interpersonales.
Postura de Trabajo	Posición relativa que adoptan los segmentos corporales del trabajador, independientemente de si se trabaja de pie o sentado.
Reconocimiento de Enfermedad profesional	Es el establecimiento de la relación causa efecto de los factores y/o agentes de riesgo laborales y una enfermedad, en base a: datos clínicos, patológicos, información básica sobre la ocupación, identificación y evaluación de los factores de riesgo de la ocupación y otros factores.
Rehabilitación profesional	Es parte de un proceso de rehabilitación integral que busca la inclusión socio-laboral del individuo.
Reinserción laboral	Proceso que tiene por objetivo que un trabajador vuelva a estar activo en el mercado laboral, desempeñando una labor profesional, después de haber estado un tiempo inactivo por cualquier causa.

Término	Definición
Requerimientos del puesto	Se definen como las aptitudes o facultades psicofísicas que debe poseer un trabajador para realizar una profesión determinada.
Requerimientos auditivos	Se valora el requerimiento de percepción de los sonidos, tanto la voz humana como indicadores acústicos. Se toma como referencia el umbral auditivo medio (UAM), para frecuencias conversacionales.
Requerimientos fonatorios	Se valoran en este apartado los requerimientos fonatorios para la realización de tareas.
Restricción en la participación	Hace referencia a los problemas que puede experimentar un individuo para implicarse en situaciones vitales.
Riesgo laboral	Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.
Ritmo	Está constituido básicamente por la repetición de un patrón sonoro y es esencial para la percepción de los acontecimientos que ocurren en el tiempo.
Rol Laboral	Se refiere a cómo llevar a cabo las tareas y acciones necesarias para ejecutar las actividades de un trabajo o empleo, de acuerdo con las actitudes y aptitudes de orden psico-cognitivo y físico de las personas, desarrolladas y acumuladas por los aprendizajes, los conocimientos, las destrezas, y las habilidades operativas, organizativas, estratégicas y resolutivas que se ponen en juego como capacidad productiva. Esta capacidad productiva se define y se mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral.
Sedestación Mantenida	Postura del trabajador en la que permanece sentado, sin posibilidad de cambios posturales.
Sensibilidad superficial o externoceptiva, termo-algésica y táctil	Sensibilidad por contacto y diversas intensidades de calor mediante el tacto. En las profesiones en las que se requiere el habitual uso de teclado informático o mecánico, se ha considerado siempre el grado de requerimiento del puesto.

Término	Definición
Sensibilidad profunda o propioceptiva	Se considera como la sensibilidad a uno o más de los siguientes criterios: barestésica (presión), batiestésica (posición articular), estereognosia (reconocimiento objetos), coordinación y estabilidad.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Es el seguro que otorga prestaciones de salud y económicas por accidentes de trabajos de alto riesgo y enfermedades profesionales a los trabajadores que colaboran en centros de trabajo en los que se desarrollan actividades consideradas de alto riesgo.
Trabajo de precisión	Exigencia de rapidez, de habilidad manual y coordinación, así como la exactitud y delicadeza de las manipulaciones a realizar y la necesidad de disponer de una correcta sensibilidad táctil en las manos.
Trabajo repetitivo	Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión.

5.2 Abreviaturas

Abreviatura	Significado
AT	Accidente de Trabajo
AVD	Actividades de la vida diaria
CENSOPAS-INS	Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud del Instituto Nacional de Salud
COMISIÓN SCTR	Comisión Calificadora de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional
EM	Evaluación Médica

EP	Enfermedad Profesional
ES	Establecimiento de salud
INR	Instituto Nacional de Rehabilitación
MINSA	Ministerio de Salud
SCTR	Seguro Complementario el Trabajo de Riesgo
VRL	Valoración del Rol Laboral

5.3 La evaluación de la incapacidad laboral por AT o EP

La evaluación de la incapacidad laboral por AT o EP se realiza en los ES públicos, privados o mixtos a partir del nivel de categorización II-2 y en las regiones que por oferta y accesibilidad no exista un ES de nivel de categorización II-2 se realiza en un ES de nivel de categorización II-1.

5.4 La calificación y certificación de la incapacidad laboral por AT o EP

La calificación y certificación de la incapacidad laboral por AT o EP se realiza por las Comisiones-SCTR conformadas en los establecimientos de salud públicos, privados o mixtos a partir del nivel de categorización III-1 según lo dispuesto en el numeral 6.3.



Esta imagen es referencial

5.5 La condición de incapacidad laboral por AT o EP

La condición de incapacidad laboral por AT o EP se acredita a través del Certificado de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional emitido por las Comisiones-SCTR.

5.6 El expediente médico

El expediente médico (que incluye la historia clínica) es susceptible de una auditoría de atención de la calidad de salud, de acuerdo con la normativa vigente.

5.7 La aseguradora del SCTR

La aseguradora del SCTR es responsable de la declaración de la invalidez, por lo que el Certificado de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional por sí sólo, no establece derecho alguno para el otorgamiento de las prestaciones económicas.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 De la solicitud para la evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional

6.1.1. Inicio de la solicitud

La solicitud para la determinación de la invalidez inicia de acuerdo con lo establecido en el Artículo N° 25 del Decreto Supremo N°003-98-SA.

6.1.2 Remisión de documentos

Con el fin de iniciar el proceso, el empleador deberá remitir a la aseguradora los documentos establecidos en el Anexo 1.

6.1.3 Solicitud del empleador

Cuando el proceso inicie a solicitud del empleador, el empleador deberá adjuntar los documentos establecidos en el anexo 1 al momento del ingreso de la solicitud dirigida a la aseguradora.

6.1.4 Plazo del empleador

Cuando el proceso inicie a solicitud del asegurado, el empleador, una vez notificado por la aseguradora del inicio del procedimiento tiene un plazo de cinco (05) días hábiles.

6.1.5 Incumplimiento del plazo

Cuando el empleador, habiendo sido notificado de la necesidad de trasladar los documentos del asegurado a la aseguradora no cumpliera con el plazo establecido; la aseguradora no podrá presentar al ES evaluador la solicitud de "Evaluación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional en el Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo".

6.1.6 Presentación al ES evaluador

La Aseguradora presenta al ES evaluador la solicitud de "Evaluación de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional en el Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo" que contiene copia del documento de identidad del asegurado y los documentos dispuestos en el Anexo 1 de la presente norma técnica de salud.

6.1.7 Presentación por persona de apoyo

Cuando por el tipo de deficiencia(s), el asegurado no puede ejercer su capacidad jurídica, la solicitud puede ser presentada por la persona designada como apoyo, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.

6.1.8 Evaluación en el ES más cercano

La aseguradora solicita la "Evaluación Médica de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" al ES evaluador más cercano al

domicilio real del asegurado. De manera excepcional, en caso que el asegurado solicite ser evaluado en otro ES, procederá previa solicitud por escrito del asegurado y aceptación de la aseguradora.

6.1.9 Cobertura de costos

La Aseguradora asume los costos relacionados con la atención de la solicitud de evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral par accidente de trabajo o enfermedad profesional, de acuerdo con el tarifario establecido por cada ES que forme parte del procedimiento.



Esta imagen es referencial

6.2 De la evaluación médica de la incapacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional

6.2.1 Especialidades y equipamiento

Para la etapa de evaluación médica (EM) de la incapacidad laboral por AT o EP se requiere que el ES disponga de:

6.2.1.1 **Consulta externa**

Consulta externa principalmente de las siguientes especialidades: Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, Medicina Física y Rehabilitación, Neumología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Ortopedia y Traumatología y Medicina Interna.

6.2.1.2 Servicio de Radiografía

Servicio de Radiografía, que cumpla con los requisitos establecidos en el anexo 10.



Esta imagen es referencial

6.2.1.3 Equipamiento de Consulta Externa

Equipamiento de Consulta Externa según se detalla a continuación:

Especialidad	Equipamiento
Neumología	• Espirómetro
Otorrinolaringología	• Audiómetro • Equipo de Potenciales Auditivos de Estado Estable (según corresponda)
Oftalmología	• Cartillas de optotipos • Pantallas o proyectores de optotipos • Campímetro computarizado
Medicina Física y Rehabilitación	• Goniómetro
Otras especialidades clínicas según corresponda	• Electrocardiograma • Ecocardiograma • Prueba de Esfuerzo • Electromiografía



Esta imagen es referencial

6.2.2 Requisitos del Establecimiento de Salud evaluador

El ES evaluador debe estar inscrito en el Registro del Ministerio de Salud para efectuar los procedimientos de evaluación médica por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

6.2.3 Subetapas de la EM de la incapacidad laboral por AT o EP

La EM de la incapacidad laboral por AT o EP contempla 4 subetapas: 1. Diagnóstico y Reconocimiento de la Enfermedad Profesional o Accidente de Trabajo. 2. Evaluación de las deficiencias. 3. Evaluación de rol laboral y 4. Evaluación de la restricción en la participación.

6.2.3.1 Subetapa 1: Diagnóstico y Reconocimiento de la Enfermedad Profesional o Accidente de Trabajo

a. La primera subetapa de la EM de la incapacidad laboral por AT o EP es realizada por el médico cirujano especialista en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente o en sus diferentes menciones debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, asimismo deberá estar registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" del MINSA.

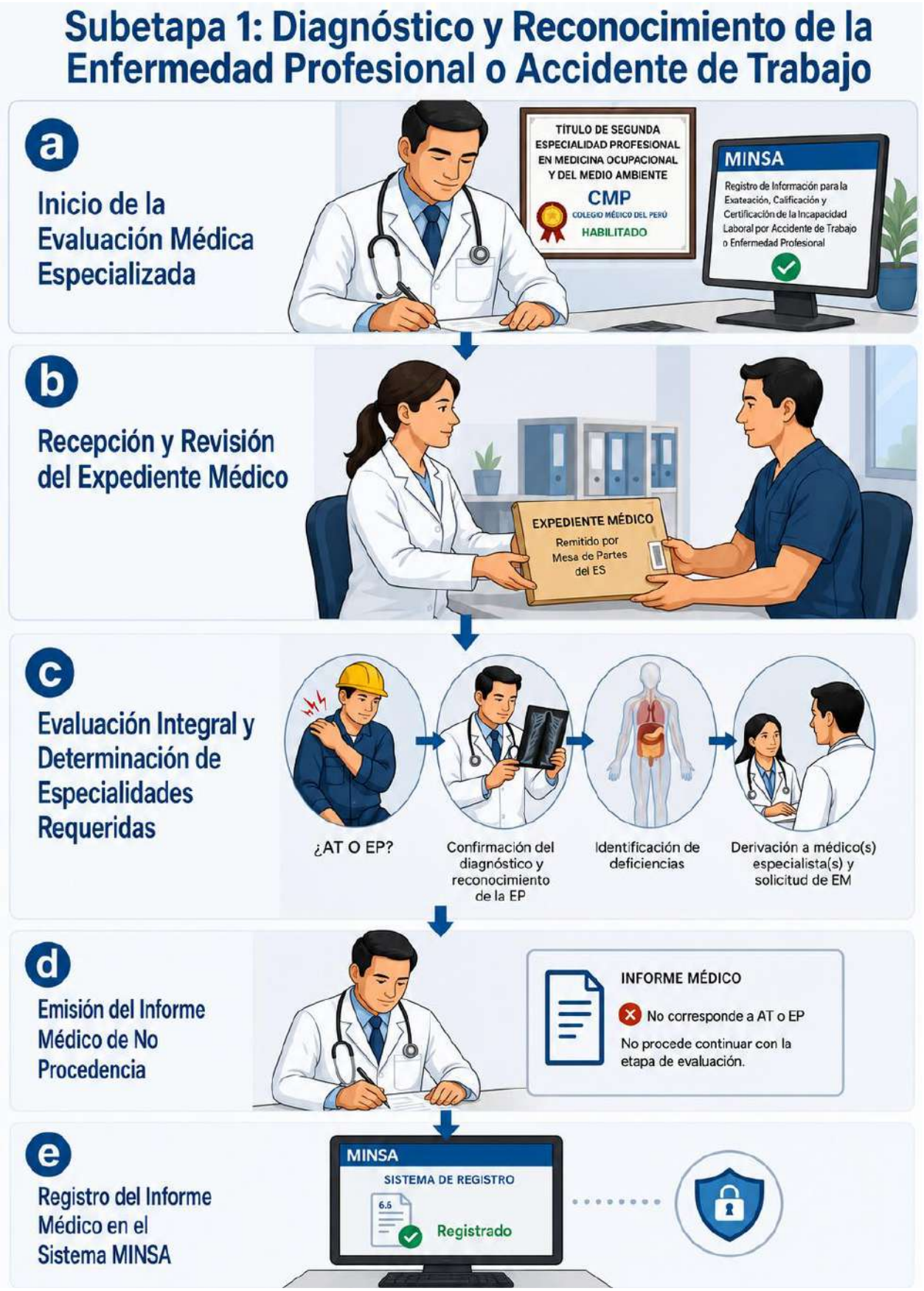
b. Dicho profesional médico recibe la documentación que contiene el expediente remitido por mesa de partes del ES.

c. El médico ocupacional realiza esta subetapa teniendo en consideración lo siguiente:

- La identificación si la evaluación de la incapacidad laboral corresponde a un AT o EP, para el caso de EP realiza la confirmación del diagnóstico y el reconocimiento de la EP.
- La identificación de las deficiencias y derivación del asegurado a los médicos especialista(s) relacionados a los órganos, aparatos y/o sistemas comprometidos, solicitando la EM.

d. En caso la incapacidad laboral no corresponda a un AT o EP, el médico ocupacional hace un informe médico e indica que no procede continuar con la etapa de evaluación.

e. El informe médico establecido en el literal d. quedará registrado en el Sistema de Registro establecido en el numeral 6.6.



Esta imagen es referencial.



Esta imagen es referencial.


FLUJO DE DIAGNÓSTICO Y RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
Caso práctico de Hipoacusia o sordera provocada por el ruido
1. Criterio del agente y enfermedad
Caso
Varón, 54 años; perforista de mina subterránea.
Dificultad para comprender habla en ruido desde 2018.
Tinnitus bilateral intermitente; sin vértigo.
Audiometría de ingreso 2004: normal.
Relacionar la enfermedad con:
Agente: ruido continuo e impacto.
CIE-10: H90.3: efecto de ruido H83.3.
Actividad: perforación, avance, voladura y limpieza.
Listado: NTS 068-MINSA.
Base legal y normativa
FUNDAMENTO: SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO.
RM 480-2008/MINSA QUE APRUEBA NTS N° 068-MINSA/DGSP-V.1 NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (grupo 2: enfermedades profesionales causadas por agentes físicos).
2. Criterio diagnóstico clínico
2.1. Revisar documentación clínica y ocupacional
2.1.1. Diagnóstico: confirmatorio sustentado en hte. Hipoacusia neurosensorial bilateral moderada
2.1.2. Exámenes complementarios históricos
Audiometría tonal: Hipoacusia neurosensorial bilateral moderada
2.1.3. Informes: sin antecedente otótico relevante
2.1.4. EMO cronológicos
2004 normal
2012 y 2018 progresión bilateral; (Método de Klockhoff)
2024 Dx confirmatorio por ORL después de evaluación completa
2025: Retiro: estabilidad
2025: Relato estabilidad
Pruebas: 2004 últimas ≥ 12 h de reposo acústico, cabina y calibración documentadas, más estudios objetivos.
2.1.5. Informes del médico ocupacional: NO
2.2. Evaluar al paciente:
2.2.1. Consideraciones clínicas:
Durante varios años de vida laboral no usó protección auditiva, posterior uso de manera irregular.
2.2.2. Signos y síntomas:
Disminución de la audición bilateral de manera progresiva desde hace 14 años; acúfenos bilaterales permanentes.
2.2.3. Exploración:
Otoscopia normal; timpanometría tipo A bilateral.
Neurológico: sin alteraciones.
2.2.4. Pruebas complementarias:
Hipoacusia Neurosensorial bilateral sintética, predominio 3 - 6KHz, 4KHz
OD: 55dB / OE: 60dB
Logoaudiometría: discriminación verbal 92% bilateral
Sin brecha aéreo-ósea ni signos retrococleares.
Potenciales evocados: elevación de los umbrales auditivos sintéticos; sin desfase interauricular lateral de onda
2.2.5. Interconsultas:
Otorrinolaringología: Diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral moderada.
3. Criterios de relación laboral
3.1. Caracterización y duración de la exposición
Revisar documentación:
A. Perfil de puesto:
Perforista de mina subterránea (Socavón)
Exposición: IPERC y otros 2004–2024 (20 años).
Perforadora jack leg: 96–100 dBA.
Frente de avance: 95–97 dBA.
Voladura y limpieza: 87–95 dBA.
Ruido continuo + impacto.
3.2. Mediciones y controles del factor de riesgo
LEX 8h por dosimetría personal:
AÑO | LEX 8h (dBA)
2005 | 97 dBA
2008 | 99 dBA
2011 | 100 dBA
2014 | 96 dBA
2017 | 96 dBA
2020 | 95 dBA
2023 | 97 dBA
Picos: 132–138 dBC.
Protección irregular hasta 2018; luego protección dual y controles.
Resultado
Exposición laboral al riesgo: documentada y previa a la enfermedad.
Duración y dosis acumulada compatibles con riesgo auditivo.
Referencia de exposición: 85dBA/8h - tasa de intercambio
Certeza de exposición: alta
4. Factores extralaborales y alternativos
Presbiacusia:
Se niega posible cofactor; no aplica baja tonal ni en la progresión temporal
Ototóxicos/químicos:
Sin aminoglucósidos, cisplatino o solventes ototóxicos sostenidos.
Otras causas:
Oído medio excluido; patrones clínicos, sin antecedentes familiares ni signos retrococleares.
No laboral:
No enfermedades crónicas ni hábitos auditivos ni hábitos de alto ruido documenta.
Conclusión:
No se identifica causa alternativa que explique la hipoacusia.
5. Informe de diagnóstico y reconocimiento de la enfermedad profesional
1 Criterio del agente y enfermedad
Evidencia científica actual sustenta que el ruido intenso puede causar daño coclear permanente.
NTS, estudios, frecuencias y dosis-respuesta.
Capacidad causal: suficiente y sustentada.
Causalidad general: alta.
2 Criterio diagnóstico clínico
Exposición previa, basal normal, progresión objetiva, exposición actualidades tras años.
Clínico, semiología y tiempo (> 14 años) coherentes con evidencia.
Compatibilidad causal e individual: alta.
Consistencia: alta certeza.
3 Criterio de relación laboral
Exposición alta; certezas de evidencia; la suficiencia del nivel y tiempo de exposición de ruido para producir hipoacusia o sordera provocada por el ruido.
4 Factores extralaborales:
Hipoacusia neurosensorial bilateral: clínica, patrón y exposición laboral: sin contraindicación causal relevante.
5 Conclusión:
Diagnóstico definitivo de Enfermedad Profesional: Hipoacusia o sordera provocada por el ruido.



FLUJO DE DIAGNÓSTICO Y RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Caso práctico de Silicosis



1. CRITERIO DEL AGENTE Y ENFERMEDAD

Caso

- Varón, 52 años; perforista de mina subterránea.
- Disnea mMRC 1 y tos seca desde 2021.
- Trabajo con roca silícea: 2005–2023.
- Radiografía de ingreso 2005: normal.

Relacionar la enfermedad con:

Agente:	sílice cristalina respirable (cuarzo).
CIE-10:	J62.8.
Actividad:	perforación, trituración y limpieza.
Listado:	NTS 068-MINSA.

Base legal y normativa

Silicosis: RM 480-2008/MINSA que aprueba NTS N°068-MINSA/DGSP-V.1 Norma Técnica de Salud que establece el listado de enfermedades profesionales (grupo 4: enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados).

2. CRITERIO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

2.1 Revisar documentación:

2.1.1 Diagnóstico confirmatorio sustentado:
Neumología: daño pulmonar compatible con silicosis.

2.1.2 Exámenes complementarios históricos:
TACAR volumétrica de baja dosis 2024: micronódulos perilinfáticos superiores y adenopatías calcificadas, sin FMP.

2.1.3. Informes:
Rx PA 2023: 2/2 secundarias calcificadoras; OIT 1/1 q/a, predominio superior bilateral.

2.1.4. EMO cronológicos:
2017–2024: Progresión radiológica documentada.

2.1.5 Informes del médico ocupacional:
Diagnóstico presuntivo de Silicosis.

2.2 Evaluar al paciente:

2.2.1 Consideraciones clínicas:
Trabajador masculino de 42 años con antecedente de exposición ocupacional durante 25 años como perforista de mina subterránea. Refiere no uso de protección respiratoria durante los primeros 15 años, luego uso regular de respirador.

2.2.2 Signos y síntomas:
Tos crónica, disnea progresiva, fatiga.

2.2.3. Exploración:
- Disnea mMRC 1 y tos seca.
- SpO_2 basal 96%.
- Caminata 6 min: 520 m; SpO_2 96→93%.

2.2.4 Pruebas complementarias:
- Radiografía OIT: compatible con Silicosis.
- TCAR: compatible con Silicosis.
- Espirometría con patrón restrictivo moderado.
- FVC 88% (>LLN), FEV, 82%; FEV_1/FVC 0,74 (>LLN); DLCO 76% (=1,8).

2.2.5 Interconsulta:
Neumología: Diagnóstico: silicosis crónica simple; biopsia no indicada en patrón típico.

3. CRITERIOS DE RELACIÓN LABORAL

3.1 Caracterización y duración de la exposición

Revisar documentación:

A. Perfil de puesto:
Perforista de mina subterránea (socavón).

- Exposición: 2005–2023 (18 años).
- Perforación de granito y arenisca.
- Trituración y zarandeo de roca.
- Limpieza con aire comprimido.
- Polvo visible frecuente; cuarzo 20–35%.

Mediciones y controles del factor de riesgo

Año	Sílice cristalina respirable, TWA 8 h
2008	0,18
2011	0,22
2014	0,28
2017	0,16
2020	0,11
2023	0,06 mg/m³

- 15/18 muestras >0,05 mg/m³.
- Control húmedo irregular; P100 continuo desde 2019.
- **Indicadores biológicos: NO.**

Resultado

- Exposición laboral al riesgo: documentada y previa a la enfermedad.
- Duración y dosis acumulada compatibles con daño diagnosticado (exposición acumulada estimada: 2.9 mg/m³-años).
- Referencia de exposición: LMP: 0.025 mg/m³; controles (EPP irregular) no óptimos.
- Certeza de exposición: alta.

4. FACTORES EXTRALABORALES Y ALTERNATIVOS

TBC:
Pruebas y cultivos negativos; sin síntomas constitucionales.

Sarcoidosis:
Sin signos extrapulmonares; exposición, gradiente apicobasal y evolución favorecen silicosis.

Otras exposiciones:
Sin carbón ni asbesto; no se identifica exposición extralaboral relevante a sílice.

Otras causas:
Sin patrón de FPI/linfangitis; neumonitis por hipersensibilidad, micobacterias no tuberculosas o neoplasia.

5. INFORME DE DIAGNÓSTICO Y RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

5.1 Criterio del agente y enfermedad:

- Evidencia científica actual sustenta que la sílice cristalina respirable puede causar silicosis.
- El riesgo aumenta con concentración, fracción respirable, contenido de SiO_2 y duración.
- Capacidad causal: establecida.
- Causalidad general: alta.

5.2 Criterio diagnóstico clínico:

- Exposición previa de larga duración: latencia hasta primera alteración aprox. 12 años.
- Dosis, OIT 1/1 y patrón típico en TCAR convergen; ninguna causa explica mejor el caso.
- Compatibilidad causal individual: alta.
- Diagnóstico: alta certeza

5.3 Criterio de relación laboral:

Exposición: alta certeza
Se evidencia la suficiencia del nivel y tiempo de exposición laboral a polvo de sílice libre para producir silicosis.

5.4 Factores extralaborales:

Silicosis crónica simple causada por exposición ocupacional a sílice cristalina respirable, sin FMP y con alteración funcional leve.

5.5 Condusión:

Diagnóstico definitivo de Enfermedad Profesional de Silicosis.

Conclusión final: Con base en la evaluación integral de los cinco criterios y la exclusión de causas alternativas relevantes, se establece el diagnóstico definitivo de Enfermedad Profesional de Silicosis.

6.2.3.2 Subetapa 2: Evaluación Médica de las Deficiencias

a. La segunda subetapa de la evaluación es realizada por el médico especialista del órgano, aparato y/o sistema comprometido que genera la incapacidad laboral; debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú; asimismo, deberá estar registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" del MINSA.

b. El médico especialista realiza una evaluación objetiva de las deficiencias que generan la pérdida funcional del trabajador asegurado, como secuela del AT o EP describiendo los signos y síntomas; puede solicitar exámenes complementarios o de ayuda diagnóstica según corresponda.

c. El médico especialista agrupa los hallazgos por clases funcionales teniendo en cuenta el documento normativo que establezca el instrumento de evaluación y calificación de la incapacidad laboral que apruebe el MINSA (Manual Nacional de Evaluación y Calificación de la Incapacidad Laboral); y determinar el diagnóstico según la Clasificación Internacional de Enfermedades vigente.

d. En caso de tratarse de médicos neumólogos o radiólogos, para el diagnóstico de neumoconiosis, debe contar con capacitación certificada de lectura de placas radiográficas en metodología OIT.

e. El médico especialista elabora el Informe de Evaluación Médica de la Incapacidad Laboral (Anexo 2) para consignar el estado de salud actual del solicitante, describe las deficiencias, la capacidad funcional y anatómica, así como los diagnósticos, secuelas y pronóstico, configurando el impedimento y sustentándolo con las evidencias obtenidas de:

- La anamnesis.
- El examen físico y mental de ser necesario
- Los resultados de pruebas de ayuda al diagnóstico.

f. El médico especialista debe emitir su informe en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de haberse cumplido con la ejecución de las evaluaciones médicas.

g. El médico especialista se encuentra prohibido de emitir pronunciamiento sobre el grado de incapacidad o menoscabo de la persona.



Esta imagen es referencial

6.2.3.3 Subetapa 3: Evaluación y Análisis del Rol Laboral

a. La tercera subetapa de la EM de la incapacidad por AT o EP es realizada por el médico cirujano especialista en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente o en su diferentes menciones, debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, asimismo, deberá estar registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" del MINSA.

b. Si el caso amerita, el médico identifica que el trabajador evaluado haya sido o sea parte de un proceso de rehabilitación profesional. La rehabilitación profesional no es requisito ni impedimento para ser evaluado por la Comisión-SCTR.

c. El médico evalúa al paciente y realiza la evaluación de los Requerimientos del Puesto de Trabajo y Capacidades del Trabajador con la documentación que contiene el expediente presentado por la entidad empleadora del trabajador asegurado:

- Capacidades del trabajador: Relacionado a las capacidades y destrezas cognitivas, físicas, psicosocial y de relación con los procesos, objetos, máquinas, herramientas y materiales propios del puesto de trabajo específico donde la persona sufre restricciones.
- Requerimientos del puesto de trabajo: Conjunto de requerimientos conformados por el lugar físico, las herramientas, tareas, deberes y responsabilidades, asignados a una persona en su ámbito laboral. Solo se debe considerar el puesto de trabajo donde el trabajador laboraba y donde haya presentado el AT o EP sin restricciones, recomendaciones ni cambios de puesto. (Anexo 3).

d. Para la evaluación del perfil del trabajador y del puesto de trabajo se considera las dimensiones de la carga física, mental y emocional, así como otros riesgos, con las siguientes fases:

Fase 1. Identifica la ocupación según la Clasificación Nacional de Ocupaciones vigente (Tabla 1) y descripción de las tareas.

Tabla 1.
Clasificación Nacional de Ocupaciones, publicado en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)

	GRANDES GRUPOS
Gran Grupo 1	Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada.
Gran Grupo 2	Profesionales científicos e intelectuales.

Gran Grupo 3	Profesionales técnicos.
Gran Grupo 4	Jefes y empleados administrativos.
Gran Grupo 5	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados.
Gran Grupo 6	Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros.
Gran Grupo 7	Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones.
Gran Grupo 8	Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte.
Gran Grupo 9	Ocupaciones elementales.
Gran Grupo 10	Ocupaciones militares y policiales.

Fase 2: Identifica las dimensiones y las variables según los puestos de trabajo (Tabla 2).

Tabla 2.
Dimensiones de la carga física, mental y emocional (*)

Dimensiones	Variable	Característica
Carga Mental	**Procesamiento de la información**	Memoria visual
		Semejanzas y diferencias
		Orientación espacial
		Conocimiento numérico
		Aprendizaje de tareas
		Lenguaje expresivo
		Conocimiento de la escritura
		Lenguaje comprensivo
		Conocimiento de la lectura
	Actitudes en el trabajo	Responsabilidad: autonomía laboral y realización de la tarea
		Repetitividad
		Atención

		Ritmo
		Organización
		Relaciones de trabajo
		Seguridad
Carga Física	**Aptitudes Físicas**	Manipulación Manual de carga
		Coordinación manipulativa
		Carga postural/Trabajo repetitivo
		Trabajo de precisión
		Sedestación Mantenida
		Bipedestación
		Marcha por terreno irregular
		Campo visual
		Agudeza visual
		Requerimiento Auditivo
		Requerimiento fonatorio
		Requerimiento de olfato y/o gusto
		Sensibilidad: superficial y/o profunda
Carga Emocional	**Carga Emocional**	Control emocional
		Relaciones Psicosociales
Otros Riesgos	**Factores Ambientales**	Ambiente térmico
		Ambiente sonoro
		Condiciones lumínicas
		Higiene ocupacional

(*) Modificado del Manual de Evaluación de Requerimientos para la Valoración de la Capacidad Laboral (MERCAL-2014). Instituto de Seguridad Social, España.

Fase 3: Evalúa los requerimientos del puesto de trabajo por cada dimensión identificada: Bajo, Medio, Alto, Muy Alto. Según tabla 3.

Tabla 3.
Nivel de Requerimientos del puesto de trabajo (*)

Requerimiento bajo:	Actividad con experiencia y que requiere un adiestramiento, entrenamiento o capacitación básica.
Requerimiento medio:	Actividades con experiencia y con un grado de adiestramiento, entrenamiento o capacitación técnica que le permita desarrollar su actividad laboral manteniendo un rendimiento habitual.
Requerimiento alto:	Actividades con experiencia y con el adiestramiento, entrenamiento o capacitación universitaria necesarios. Se define como exigencia laboral intensa o "cualificada".
Requerimiento muy alto:	Actividades con experiencia y especialmente adiestrada, entrenada o capacitación universitaria avanzado (postgrado). Se define como exigencia laboral especialmente intensa.

(*) Modificado del Manual de Evaluación de Requerimientos para la Valoración de la Capacidad Laboral (MERCAL-2008). Instituto de Seguridad Social, España.

Fase 4: Evalúa las Capacidades del trabajador para lo cual se categoriza cada dimensión, de acuerdo a la evaluación de las deficiencias según el órgano o sistema afectado: sin dificultad, con dificultad no significativa, con dificultad leve, con dificultad moderada, con dificultad severa, sin capacidad. Según Tabla 4.

Tabla 4.
Nivel de Capacidades del Trabajador (*)

Sin dificultad:	Puede realizar sus actividades laborales sin dificultad.
Con dificultad no significativa:	Puede realizar sus actividades laborales en calidad y/o cantidad con dificultad no significativa.
Con dificultad leve:	Puede realizar sus actividades laborales en calidad y/o cantidad con dificultad leve.
Con dificultad moderada:	Puede realizar sus actividades laborales en calidad y/o cantidad con dificultad moderada
Con dificultad severa:	Puede realizar sus actividades laborales en calidad y/o cantidad con dificultad severa
Sin Capacidad:	No puede realizar actividades

(*) Modificado del Manual de Evaluación de Requerimientos para la Valoración de la Capacidad Laboral (MERCAL). Instituto de Seguridad Social, España.

Fase 5: Realiza comparación de los requerimientos según las dimensiones; para las capacidades del trabajador, para lo cual se realiza un análisis médico-ocupacional por cada caso en específico, y se otorga un puntaje de Rol Laboral del 0 al 5, de acuerdo al Anexo 5 tomando en cuenta la Tabla 5.

Tabla 5.
Puntaje del Rol Laboral según Requerimientos del Puesto y Capacidades del Trabajador

Requerimiento/Capacidades	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Sin dificultad:	0	0	0	0
Con dificultad no significativa:	1	1	2	2
Con dificultad leve:	2	2	3	3
Con dificultad moderada:	3	3	4	4
Con dificultad severa:	4	4	5	5
Sin capacidad:	5	5	5	5

(*) Elaborado por la Unidad Funcional de Salud Ocupacional e Incapacidad Laboral, DENOT-DGIESP/MINSA

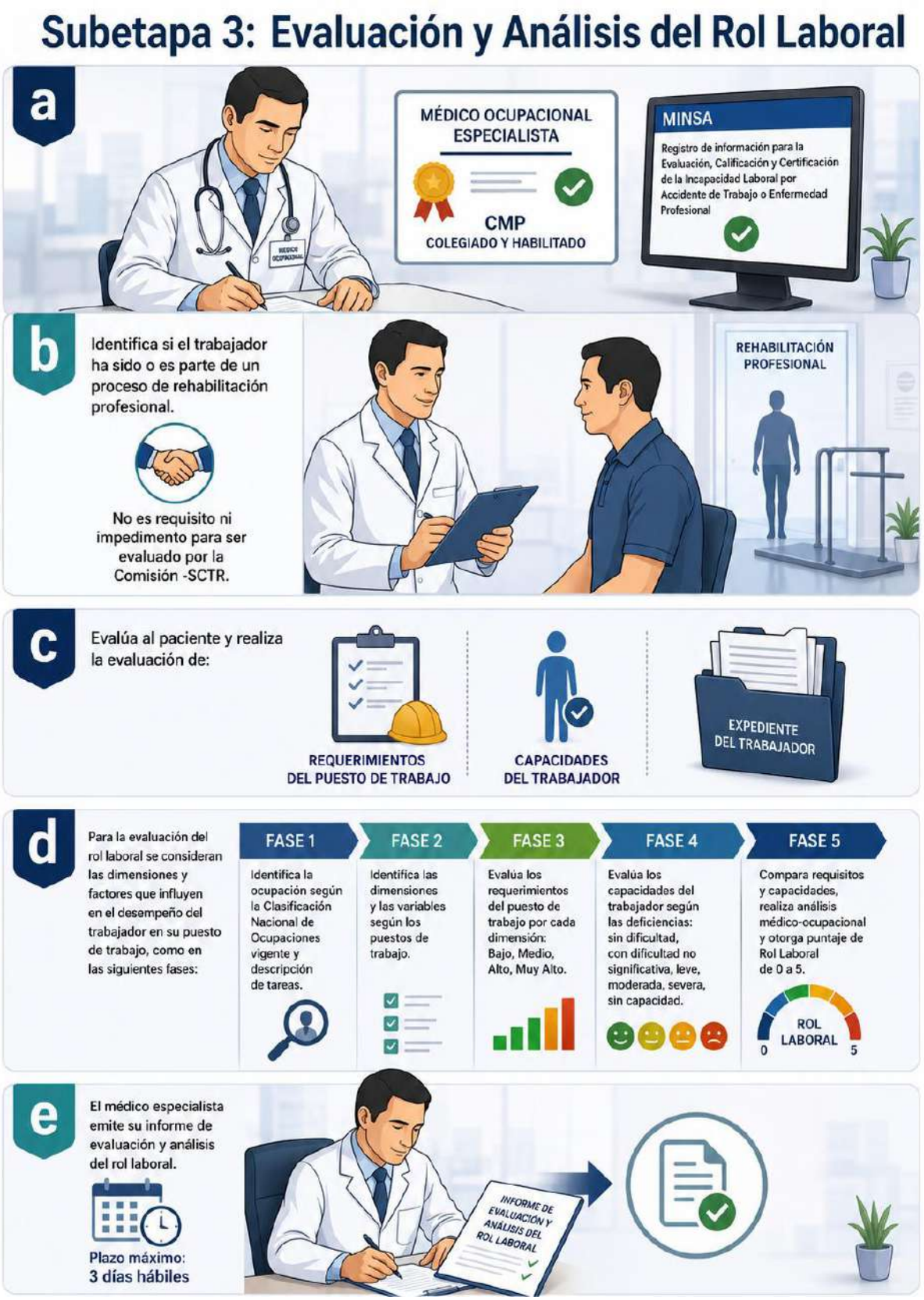
Si el nivel de capacidades es valorado sin dificultad, independientemente del nivel de requerimiento del puesto de trabajo el nivel del Rol Laboral será de 0.

Si el nivel de capacidades es valorado sin capacidad independientemente del requerimiento del puesto de trabajo el puntaje del Rol Laboral será de 5.

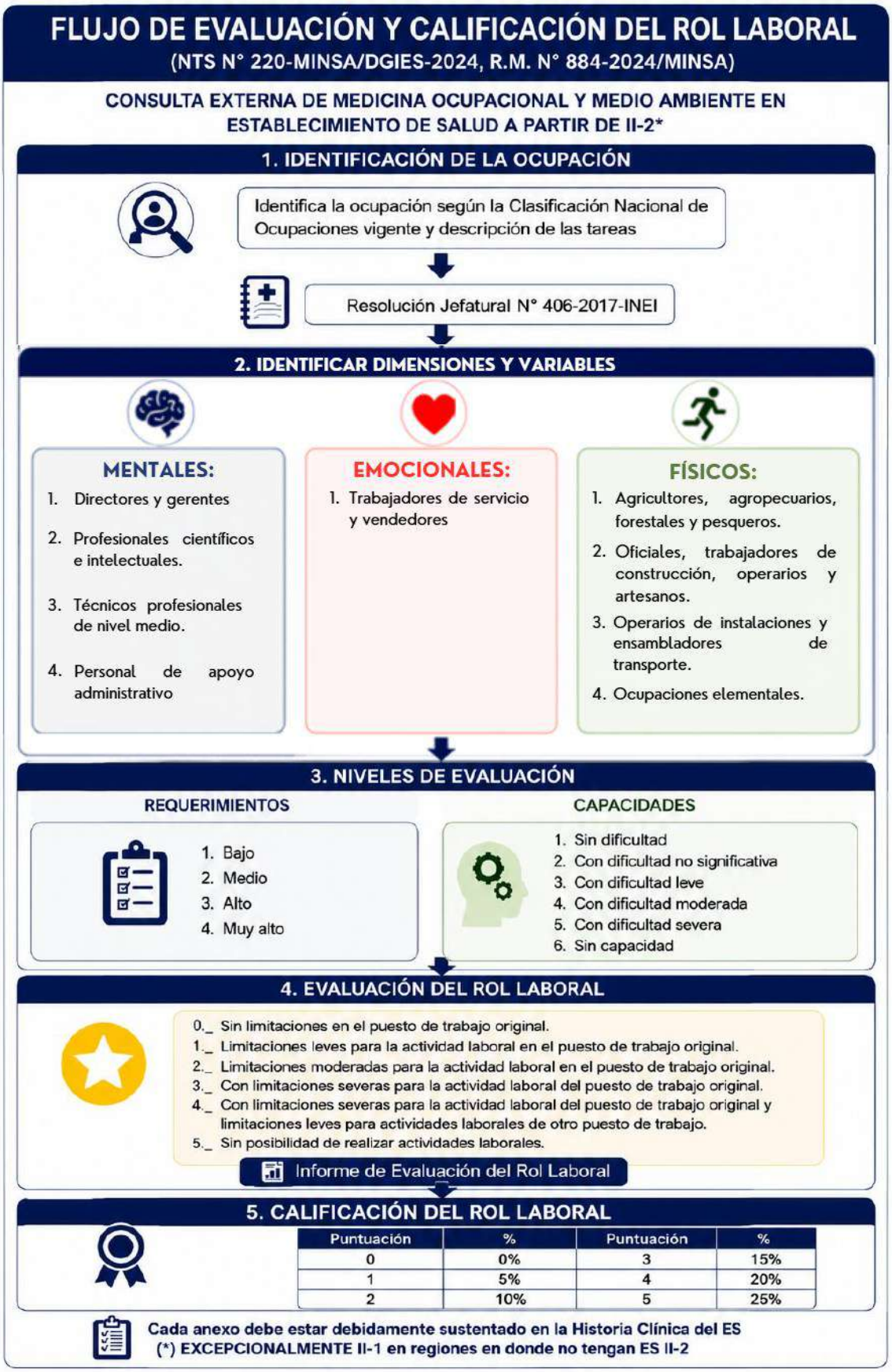
En los requerimientos del puesto de trabajo que presenten más de una característica en la misma o en diferentes variables y/o dimensiones, se tomara en cuenta la característica de mayor nivel.

e. El médico especialista en Medicina Ocupacional y Medio Ambiental o en sus diferentes menciones completa los formatos correspondientes al Informe de evaluación del rol laboral. (Anexo 5).

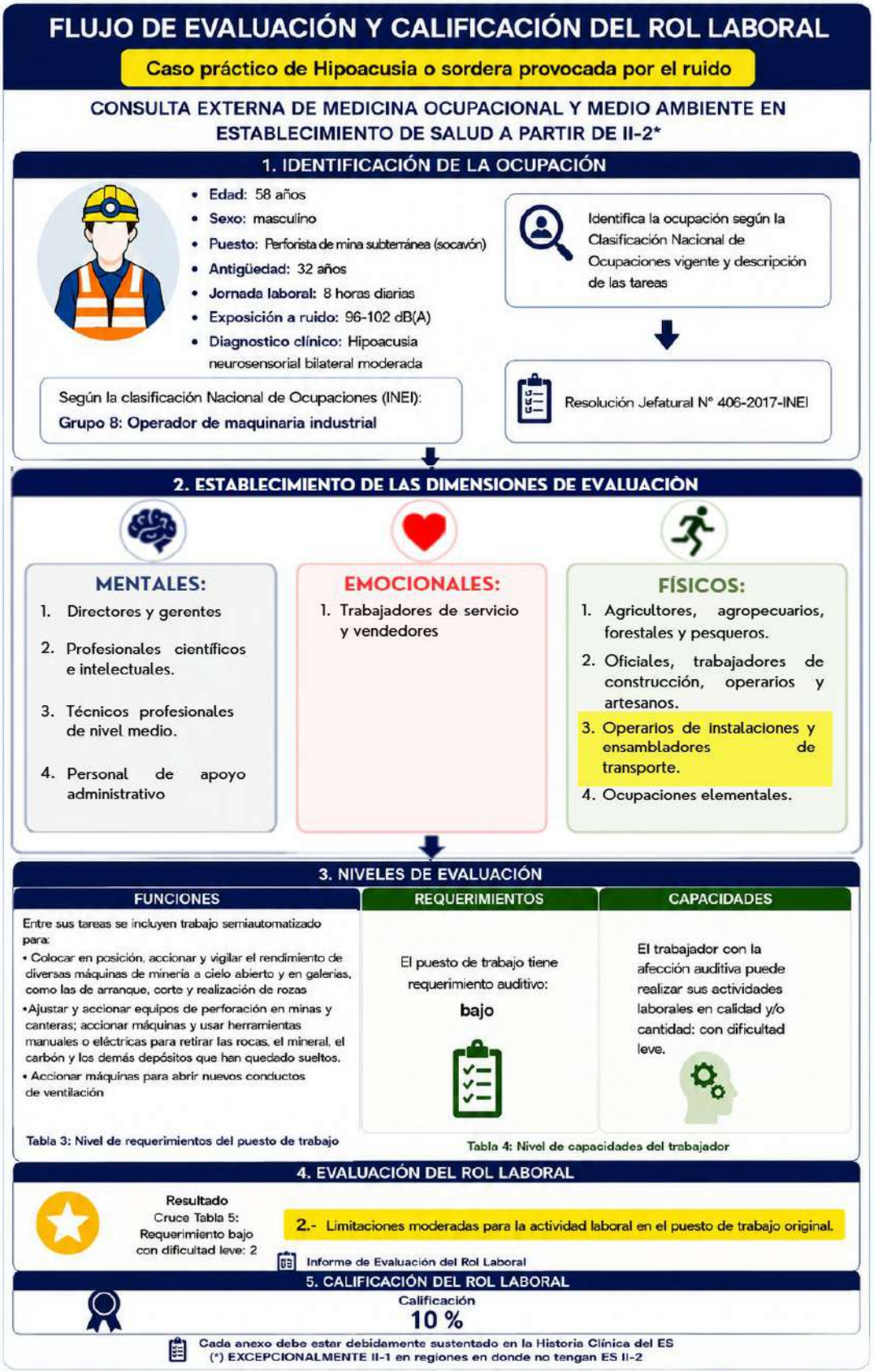
f. El médico especialista debe emitir su informe de evaluación y análisis del rol laboral en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles de haberse cumplido con la ejecución de la evaluación.



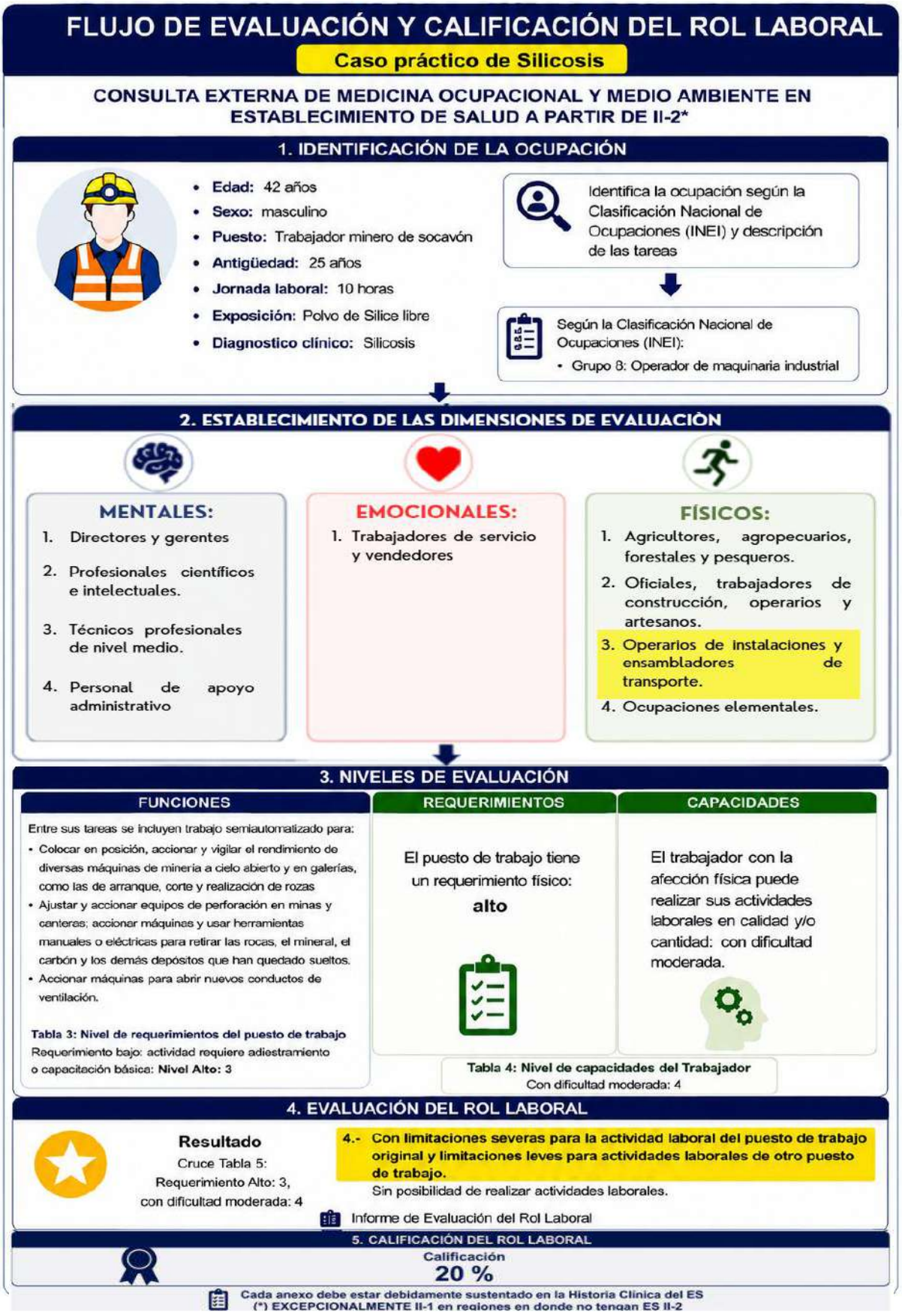
Esta imagen es referencial



Este flujo es referencial



Este flujo de caso práctico es referencial



Este flujo de caso práctico es referencial

6.2.3.4 Subetapa 4: Evaluación de la Restricción en la Participación

a. La cuarta subetapa de la EM de la incapacidad por AT o EP es realizada por el médico cirujano especialista en Medicina Física y Rehabilitación o en sus diferentes menciones, debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, asimismo, deberá estar registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" del MINSA.

b. La evaluación de la restricción en la participación hace referencia a los problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales.

c. Para evaluar la restricción en la participación se debe tener en cuenta los siguientes criterios: Capacidad de la ejecución, dependencia y uso de producto, instrumentos, equipo o sistema técnico de apoyo.

d. Las categorías por considerar en esta subetapa de evaluación son: Aprendizaje y Aplicación del conocimiento, Comunicación, Movilidad, Cuidado Personal, Vida doméstica y Vida económica.

e. La elección de categorías a evaluar se hace de acuerdo a la evaluación de las deficiencias según el órgano o sistema afectado.

f. El médico especialista debe completar el Anexo 6 de Evaluación de la restricción en la participación y emitir el informe en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles.

6.2.4

Para el inicio de sus funciones, los médicos evaluadores deberán demostrar cursos de especialización o de postgrado de incapacidad laboral y/o capacitaciones en evaluación de la incapacidad laboral por AT o EP otorgadas por la DGIESP del MINSA.

6.2.5

Los médicos especialistas que realizan la etapa de evaluación no deben de tener conflicto de intereses con la aseguradora y el asegurado.



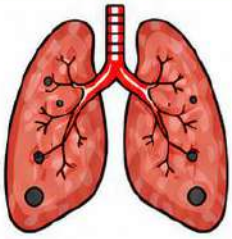
Esta imagen es referencial

FLUJO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

(NTS N° 220-MINSA/DGIES-2024, R.M. N° 884-2024/MINSA)

Caso práctico de Silicosis

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD A PARTIR DE II-2*



Sillicosis (1/1 q)

Espirometría restrictiva moderada.

CALIFICACIÓN DE DEFICIENCIA: **5.5%**



REQUERIMIENTO MEDIO, DIFICULTAD LEVE.

IMPACTO EN EL ROL: **20%** (PUNTAJE: 4)

NIVEL DE DEPENDENCIA EN LA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

NIVEL C. Dificultad moderada - dependencia moderada.

La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, en la ejecución de las tareas y demandas generales, de la comunicación y de la vida económica y domestica, requiere del uso de ayudas técnicas para la ejecución de estas.

FASE	ACTIVIDAD DE LA VIDA DIARIA	INCISOS AFECTADOS	PUNTAJE
1	Aprendizaje y conocimiento	Ninguno	0%
2	Comunicación	Ninguno	0%
3	Movilidad	• 3.1 Mantener la posición del cuerpo. (0.4) • 3.2 Levantar y llevar objetos. (0.4) • 3.5 Andar y desplazarse por el entorno. (0.4)	1.2%
4	Cuidado Personal	Ninguno	0%
5	Vida Doméstica	• 5.2 Adquisición de bienes y servicios. (0.4) • 5.3 Realizar los quehaceres de la casa. (0.4)	0.8%
6	Vida Económica	• 6.2 Transacciones económicas complejas. (1)	1%
	PUNTAJE TOTAL		3%

Este cálculo sigue la metodología de evaluación y calificación de incapacidad laboral con base en deficiencias, rol laboral, participación (AVD) y factores demográficos.

(*) EXCEPCIONALMENTE II-1 en regiones en donde no tengan ES II-2

Esta imagen es referencial

FLUJO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

(NTS N° 220-MINSA/DGIES-2024, R.M. N° 884-2024/MINSA)

Caso práctico de Hipoacusia o sordera provocada por el ruido

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD A PARTIR DE II-2*



A. DX. HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO

Audiometría tonal: Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Moderada

CALIFICACIÓN DE DEFICIENCIA: 15%



B. REQUERIMIENTO BAJO, DIFICULTAD LEVE.

IMPACTO EN EL ROL: 10% (PUNTAJE 2)

NIVEL DE DEPENDENCIA EN LA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

NIVEL C. Dificultad moderada - dependencia moderada.

La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, en la ejecución de las tareas y demandas generales, de la comunicación y de la vida económica y domestica, requiere del uso de ayudas técnicas para la ejecución de estas.

FASE	ACTIVIDAD DE LA VIDA DIARIA	INCISOS AFECTADOS	PUNTAJE
1	Aprendizaje y conocimiento	1.2 Escuchar. (0.4)	0.4%
2	Comunicación	2.1 Comunicarse con recepción de mensajes verbales. (0.4) 2.3 Habla. (0.4) 2.5 Conversación. (0.4)	1.2%
3	Movilidad	Ninguno	0%
4	Cuidado Personal	4.5 Cuidado de la propia salud. (0.4)	0.4%
5	Vida Doméstica	5.2 Adquisición de bienes y servicios. (0.4) 5.3 Realizar los quehaceres de la casa. (0.4) 5.5 Ayudar a los demás. (0.4)	1.2%
6	Vida Económica	6.2 Transacciones económicas complejas. (1)	1%
	PUNTAJE TOTAL		4.2%

Este cálculo sigue la metodología de evaluación y calificación de incapacidad laboral con base en deficiencias, rol laboral, participación (AVD) y factores demográficos.

(*) EXCEPCIONALMENTE II-1 en regiones en donde no tengan ES II-2

Esta imagen es referencial

6.3 De La Conformación de las Comisiones Calificadoras de Incapacidad Laboral Por Accidente De Trabajo o Enfermedad Profesional

6.3.1.

Las Comisiones-SCTR tienen jurisdicción macrorregional y se implementan en los establecimientos de salud públicos, privados o mixtos a partir del nivel de categorización III-1 de las capitales de las regiones de mayor densidad poblacional afiliada al SCTR, tomando en cuenta la siguiente distribución:

- Macro Región Norte con sede en la ciudad de Trujillo: Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.
- Macro Región Centro con sede en la ciudad de Huancayo: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Huancayo, Pasco e Ica.
- Macro Región Sur con sede en la ciudad de Arequipa: Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
- Macro Región Oriente con sede en la ciudad de Iquitos: Amazonas. Loreto, San Martín y Ucayali.
- Macro Región Lima con sede en la ciudad de Lima: Callao, Cañete, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este.



Esta imagen es referencial

6.3.2. Las Comisiones-SCTR se oficializan por Resolución Directoral del ES correspondiente. En el subsector privado las Comisiones-SCTR se oficializan mediante documento oficial emitido por el Director Médico. Bajo responsabilidad, el ES debe remitir copia de la resolución o documento que oficializa la Comisión-SCTR a la Oficina de Normalización Provisional-ONP, a las Aseguradoras privadas y a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de dicha oficialización.

6.3.3. La Comisión- SCTR se conforma para un periodo de dos (2) años. La Comisión-SCTR está encargada de atender las solicitudes de calificación del grado de la incapacidad laboral, así como de emitir el Certificado Médico de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

6.3.4. La Comisión-SCTR está conformadas por cinco (5) miembros que son personal de la salud y un (1) profesional de abogacía propio del ES, conforme a lo siguiente:

a. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" y con 3 años de experiencia profesional como mínimo.

b. Médico especialista en Medicina Ocupacional o Médico con Grado de Maestría en Medicina Ocupacional debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" y con 3 años de experiencia profesional como mínimo.

c. Médico especialista en otorrinolaringología debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" y con 3 años de experiencia profesional como mínimo.

d. Médico especialista en Neumología debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, registrado en el "Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" y con 3 años de experiencia profesional como mínimo.

e. Licenciado en Psicología debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio de Psicólogos del Perú y con 3 años de experiencia profesional en Salud Ocupacional como mínimo.

f. Abogado debidamente titulado, colegiado y habilitado, como mínimo con 1 año de experiencia profesional en el sector público, acreditada en materia de: Seguridad Social en Salud, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Calificación de Incapacidad Laboral o Derechos de la Persona con Discapacidad.



Esta imagen es referencial

6.3.5. La presidencia de la Comisión-SCTR recae en el profesional médico con mayor antigüedad en el ejercicio profesional.

6.3.6. La secretaría de la Comisión-SCTR recae en el médico especialista en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente o Médico con Grado de Maestría en Medicina Ocupacional.

6.3.7. Cada miembro de la Comisión-SCTR cuenta con un suplente designado por el Director del ES. Los miembros suplentes en los casos de Neumología y Otorrinolaringología deben ser reemplazados por médicos de las mismas especialidades, siempre que la calificación sea referida a enfermedades auditivas y pulmonares. En caso se trate de la calificación de otros diagnósticos, los suplentes de la comisión SCTR pueden ser especialistas en medicina interna y ortopedia y traumatología.

6.3.8. Para el inicio de sus funciones, profesionales de la salud y abogacía titulares y suplentes que conforman la Comisión-SCTR deberán demostrar cursos de especialización o de postgrado de incapacidad laboral, o salud ocupacional o afines.

6.3.9. Cada miembro titular y suplente no debe mantener conflicto de intereses previo al inicio de la calificación de cada caso, y debe firmar una declaración jurada de tal hecho.

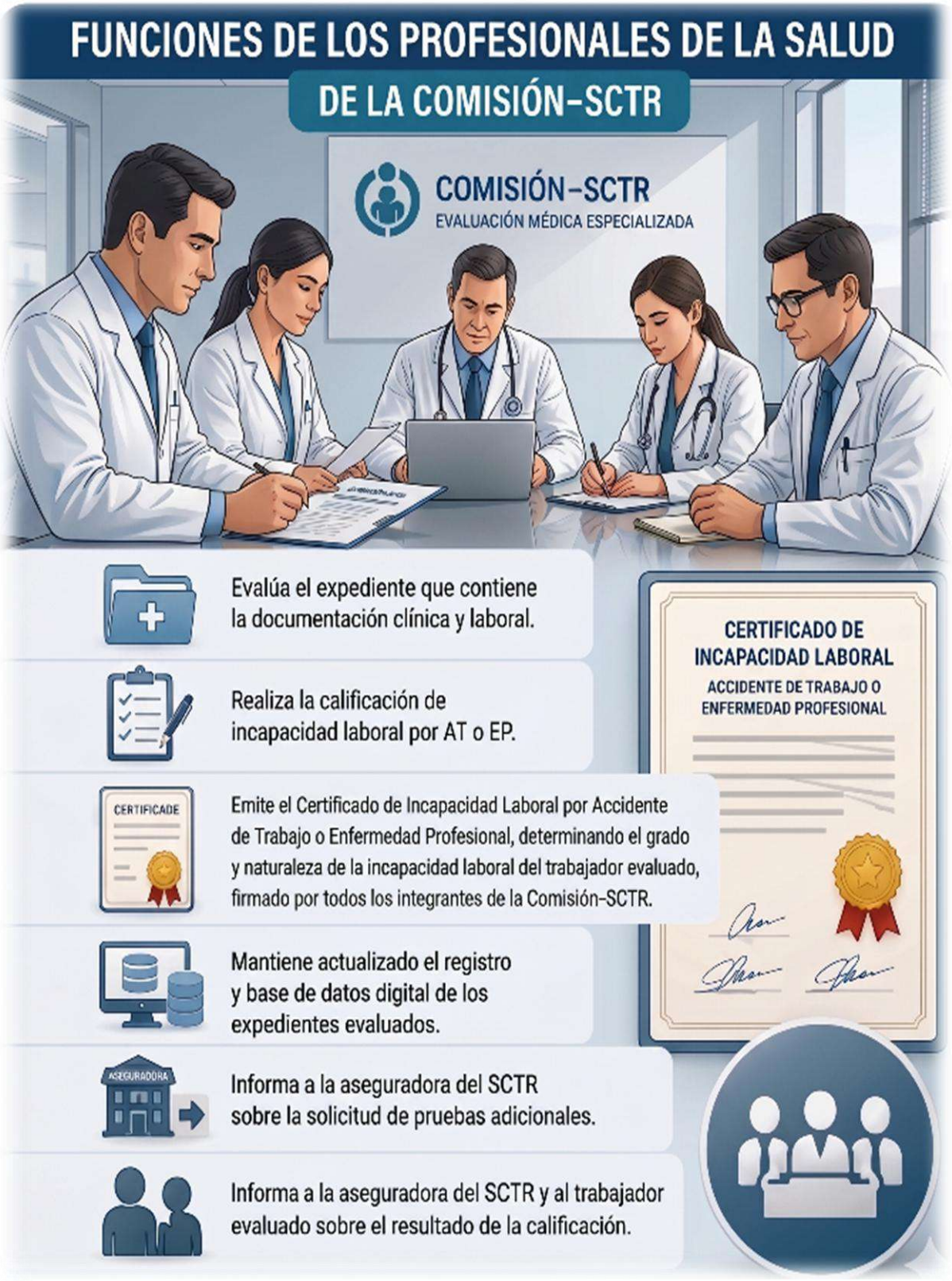
6.3.10. En caso de renuncia o cese de algún miembro, se debe designar a su reemplazo por el periodo de vigencia faltante, dicha designación se oficializa según lo indicado en el subnumeral 6.3.3.

6.3.11. En ningún caso, los médicos integrantes del Comité Calificador del SCTR del INR como Única Instancia Administrativa pueden integrar las Comisiones-SCTR de los establecimientos de salud públicos y privados y además no podrá tener conflicto de intereses con las Aseguradoras.

6.3.12. La Comisión-SCTR se reúne como mínimo dos (2) veces al mes de manera ordinaria, o extraordinaria, según la demanda de atención de solicitudes para la calificación y emisión de los Certificados Médicos.

6.3.13. La Comisión-SCTR debe contar con un Libro de Actas, que contiene el desarrollo de las sesiones; así como con un archivo en físico de toda la documentación y complementariamente una carpeta digital de los Certificados Médicos de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional emitidos con una numeración correlativa y datos relevantes.

6.3.14. Las funciones de los profesionales de la salud de la Comisión-SCTR son:



Esta imagen es referencial

6.3.15. Las funciones de los profesionales de abogacía de la Comisión-SCTR son:



Esta imagen es referencial

6.3.16. En caso de ausencia del presidente de la Comisión-SCTR a una de las sesiones de la comisión, esta será presidida por el miembro suplente, y en caso de ausencia de este último asume la presidencia para dicha sesión el siguiente miembro con mayor antigüedad en el ejercicio profesional.

6.3.17. Son responsabilidades del presidente de la Comisión-SCTR:

- Preside las sesiones de la comisión, mantiene el orden y permite que todos los miembros tengan la oportunidad de expresar sus opiniones.
- Dirige, convoca y organiza las sesiones de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias.
- Supervisa y dirige todo el proceso de evaluación y calificación de la incapacidad laboral.
- Representa a la comisión ante las autoridades y las diversas entidades públicas y privadas.
- Supervisa y revisa la calidad de los informes médicos emitidos por los médicos especialistas y/u otros exámenes auxiliares complementarios solicitados.
- Vela por el correcto cumplimiento de los acuerdos adoptados por la comisión.
- Firma el acta, certificado o acuerdo de cada sesión de la comisión, conjuntamente con los demás miembros.
- Aprueba la agenda de los temas que se tratarán en cada sesión de la comisión.

6.3.18. Son responsabilidades del secretario de la Comisión-SCTR:

- Administra y custodia en carpeta física y un respaldo en carpeta digital que contenga toda la documentación de la comisión, firmada y escaneada en formato PDF.
- Ingresa la información al Sistema de Registro de información para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional de MINSA.
- Administra y custodia el libro de Actas.
- Coordina la elaboración de documentos que se generen y que se requieran.
- Convoca a reuniones ordinarias o extraordinarias.

6.3.19. Las facultades de la Comisión-SCTR son:

- De ser necesario, cita al trabajador asegurado para la evaluación y valoración correspondiente.
- Solicita la evaluación e informes de los médicos u otros profesionales especialistas según la lesión por el AT o EP.
- Solicita exámenes y evaluaciones complementarias, diferentes a los acompañados en el expediente que considere indispensables para fundamentar su calificación y certificación.
- De considerarlo necesario, solicita antecedentes e informes adicionales a las Aseguradoras, Establecimientos de Salud que hayan atendido al trabajador por las contingencias laborales y Entidades Empleadoras.



Esta imagen es referencial

6.3.20. Los miembros de la Comisión-SCTR deben abstenerse de formar parte del proceso de calificación en los siguientes supuestos:

- Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los trabajadores asegurados solicitantes o tuviere interés en el resultado del procedimiento de certificación médica.
- Si ha prestado servicios profesionales como médico tratante, asesor, perito o testigo contratado por el trabajador asegurado solicitante, las aseguradoras (incluida la Oficina de Normalización Previsional), sus representantes o los abogados designados en el procedimiento.
- Cuando algún integrante de la Comisión-SCTR incurra en algún conflicto de intereses en los últimos doce (12) meses, distinto a los señalados en los apartados precedentes, con cualquiera de los intervinientes en el procedimiento de certificación médica en el referido procedimiento, se abstendrán de participar en la calificación en el referido procedimiento, expresando los motivos de dicha decisión a la Comisión-SCTR.

En cualquiera de los supuestos mencionados en el presente numeral, el miembro cuya abstención es comunicada a la Comisión-SCTR, será sustituido por el miembro suplente.

6.3.21. La Comisión-SCTR cuenta con el apoyo administrativo permanente para el ejercicio de sus funciones.

6.4 De La Calificación de la Incapacidad Laboral Por Accidente De Trabajo o Enfermedad Profesional

6.4.1 La aseguradora solicita la "Calificación y Certificación de la Incapacidad laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional" a través del Sistema de Registro, al ES que conforme la Comisión-SCTR de la capital de la región donde se haya realizado la evaluación o en su defecto al ES que conforme la Comisión-SCTR en la sede de la macrorregión a la que pertenece según lo establecido numeral 6.3.1 de la presente Norma Técnica de Salud.

6.4.2 La Comisión-SCTR realiza la calificación que consiste en valorar objetivamente la gravedad de la incapacidad, el rango de calificación oscila entre un mínimo de cero por ciento (0%) y un máximo de cien por ciento (100%), correspondiendo, cincuenta por ciento (50%) a la calificación de las deficiencias y el otro cincuenta ciento (50%) a la Valoración del Rol Laboral y de la Restricción en la Participación.

6.4.3 La Comisión-SCTR establece el porcentaje de las deficiencias utilizando el instrumento de evaluación y calificación de la incapacidad laboral (Manual Nacional de Evaluación y Calificación del Grado de Incapacidad) aprobado por el MINSA; para los casos en que se encuentren afectados dos o más órganos o sistemas, aplicando la fórmula de Balthazar o de suma combinada: A + [(100 – A)xB/100], donde "A" es

la deficiencia de mayor valor y "B" la deficiencia de menor valor. Posterior a la obtención del porcentaje global de las deficiencias, se multiplicará por "0.5" que corresponde a la calificación de la deficiencia (50%) del menoscabo de la capacidad laboral.

6.4.4 Para la calificación del rol laboral y restricción en la participación, la Comisión-SCTR sumará aritméticamente los resultados de calificación de las Restricciones del Rol Laboral más el resultado de la calificación de las Restricciones del Rol de Participación, más la calificación de la edad (Anexo 7 y 8).

6.4.5 Para la calificación de la incapacidad laboral, la Comisión-SCTR realiza una suma aritmética del porcentaje obtenido en la calificación de las deficiencias (hasta un 50%) y del porcentaje obtenido de la calificación del rol laboral y restricción en la participación (hasta un 50%) según la distribución de la Tabla 6.



Esta imagen es referencial

Tabla 6. Calificación de la Incapacidad Laboral *

CALIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS	CALIFICACIÓN DEL ROL LABORAL Y RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN		
Deficiencias	Restricciones y Capacidades Laborales	Restricción en la participación	Edad
			
Se evalúan las deficiencias del funcionamiento corporal, incluyendo estructuras y funciones del cuerpo.	Se valoran las restricciones y capacidades para el desempeño de actividades y tareas laborales.	Se analiza el impacto de la condición de salud en la participación en situaciones de la vida diaria.	Se considera la edad de la persona como factor de ajuste en la calificación.
50%	25%	22%	3%
Σ	≤ 100% La suma total de los componentes no puede exceder el 100%.		

* De acuerdo con la Resolución Ministerial que aprueba la Tabla de Evaluación de Incapacidades.
** Adaptado de Ministerio de Trabajo, Manual Único para la Calificación de la Perdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, MINTRABAJO, Colombia: 2014.

Esta imagen es referencial

CASO 01: DEFICIENCIA ÚNICA
(HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO)



A. DX. HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO

Audiometría tonal: Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Moderada

CALIFICACIÓN DE DEFICIENCIA: 15%



B. REQUERIMIENTO BAJO, DIFICULTAD LEVE.

IMPACTO EN EL ROL: 10% (PUNTAJE 2)

FASE 1
EVALUACIÓN MÉDICA DE LAS DEFICIENCIAS



DEFICIENCIA EVALUADA



HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO
(klockhoff moderado)
Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Moderada
Deficiencia asignada 15%

DEFICIENCIA ASIGNADA
15%

Nota: En la valoración de la deficiencia auditiva, el porcentaje obtenido mediante el método específico establecido por la NTS N.° 223-MINSA/DGIESP-2024 se considera directamente como porcentaje de deficiencia y no se multiplica por el factor 50%

FASE 2
EVALUACIÓN DEL ROL LABORAL



VARÓN DE 58 AÑOS
Perforista de mina subterránea (socavón)
(32 años de exposición a ruido)

TAREAS CRÍTICAS DEL PUESTO:
a) Operador de perforadora (Jack Leg): 100dB(A)
b) Perforación de frentes: 98dB(A)
c) Permanencia durante voladuras: 95dB(A)
d) Limpieza posterior a voladura: 87dB(A)

IMPACTO EN EL ROL: 10% (PUNTAJE 2)

FASE 3
RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN (AVD)



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)

Aprendizaje y conocimiento	Comunicación	Movilidad	Cuidado Personal	Vida Doméstica	Vida Económica
0%	0%	1.6%	0%	0.8%	1%

PUNTUACIÓN CASO 01: 4.2%

FASE 4
CLASIFICACIÓN POR EDAD

FACTOR DEMOGRÁFICO FIJO
(Mayor o igual a 50 años, menor de 60 años) **2%**

FASE 5
CÁLCULO DEL MENOSCABO FINAL

FÓRMULA DE CÁLCULO

$\sum$ = 15% (Def. asignada) + 10% (Rol laboral) + 4.2% (AVD) + 2% (Edad)

RESULTADO FINAL CASO 01: 31.2%

NOTA: Para la deficiencia auditiva no se aplica el factor de ponderación del 50%; se incorpora directamente el porcentaje determinado según el procedimiento específico de evaluación auditiva de la NTS N.° 223-MINSA/DGIESP-2024.

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE DE EVALUACIÓN	CASO 01 (Hipoacusia o sordera provocada por el ruido)	PORCENTAJE (%) MÁXIMO ASIGNADO
1. Deficiencias Médicas	15%	50%
2. Rol Laboral	10%	25%
3. Participación (AVD)	4.2%	22%
4. Edad (50-60 años)	2%	3%
MENOSCABO TOTAL	31.2%	≤ 100%

Este cálculo sigue la metodología de evaluación y calificación de incapacidad laboral con base en deficiencias, restricciones en la participación y factores individuales.

La imagen del caso es referencial.

CASO 02: DEFICIENCIA ÚNICA (SILICOSIS)



Silicosis (1/1 q)
Espirometría restrictiva moderada.

CALIFICACIÓN DE DEFICIENCIA: **5.5%**



REQUERIMIENTO MEDIO, DIFICULTAD LEVE.

IMPACTO EN EL ROL: **20%** (PUNTAJE: 4)

FASE 1
EVALUACIÓN MÉDICA DE LAS DEFICIENCIAS

DEFICIENCIA EVALUADA



Silicosis (1/1 q)
Espirometría restrictiva moderada.

- Deficiencia respiratoria evaluada: 11 %
- Ponderación aplicable: 50 %
- Deficiencia asignada: 11 % × 50 % = 5.5 %

DEFICIENCIA ASIGNADA: **5.5%**

FASE 2
EVALUACIÓN DEL ROL LABORAL

VARÓN DE 42 AÑOS
Operario de Lubricación en Mina Socavón
(25 años exposición a polvo)

TAREAS CRÍTICAS DEL PUESTO:

- Mantenimiento, ensamblaje y limpieza de equipos mineros.
- Carga: 60% física, 40% mental.
- Jornada de 10 horas.

IMPACTO EN EL ROL: **20%** (PUNTAJE: 4)

FASE 3
RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN (AVD)

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)

Aprendizaje y conocimiento	Comunicación	Movilidad	Cuidado Personal	Vida Doméstica	Vida Económica
0%	0%	1.2%	0%	0.8%	1%

PUNTUACIÓN CASO 02: **3.0%**

FASE 4
CALIFICACIÓN POR EDAD

FACTOR DEMOGRÁFICO FIJO **1.0%**
(Mayor igual a 40 años, menor de 50 años)

FASE 5
CÁLCULO DEL MENOSCABO FINAL

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum = 5.5\% \text{ (Def. Final Ajustada)} + 20\% \text{ (Rol Laboral)} + 3.0\% \text{ (AVD)} + 1\% \text{ (Edad)}$$

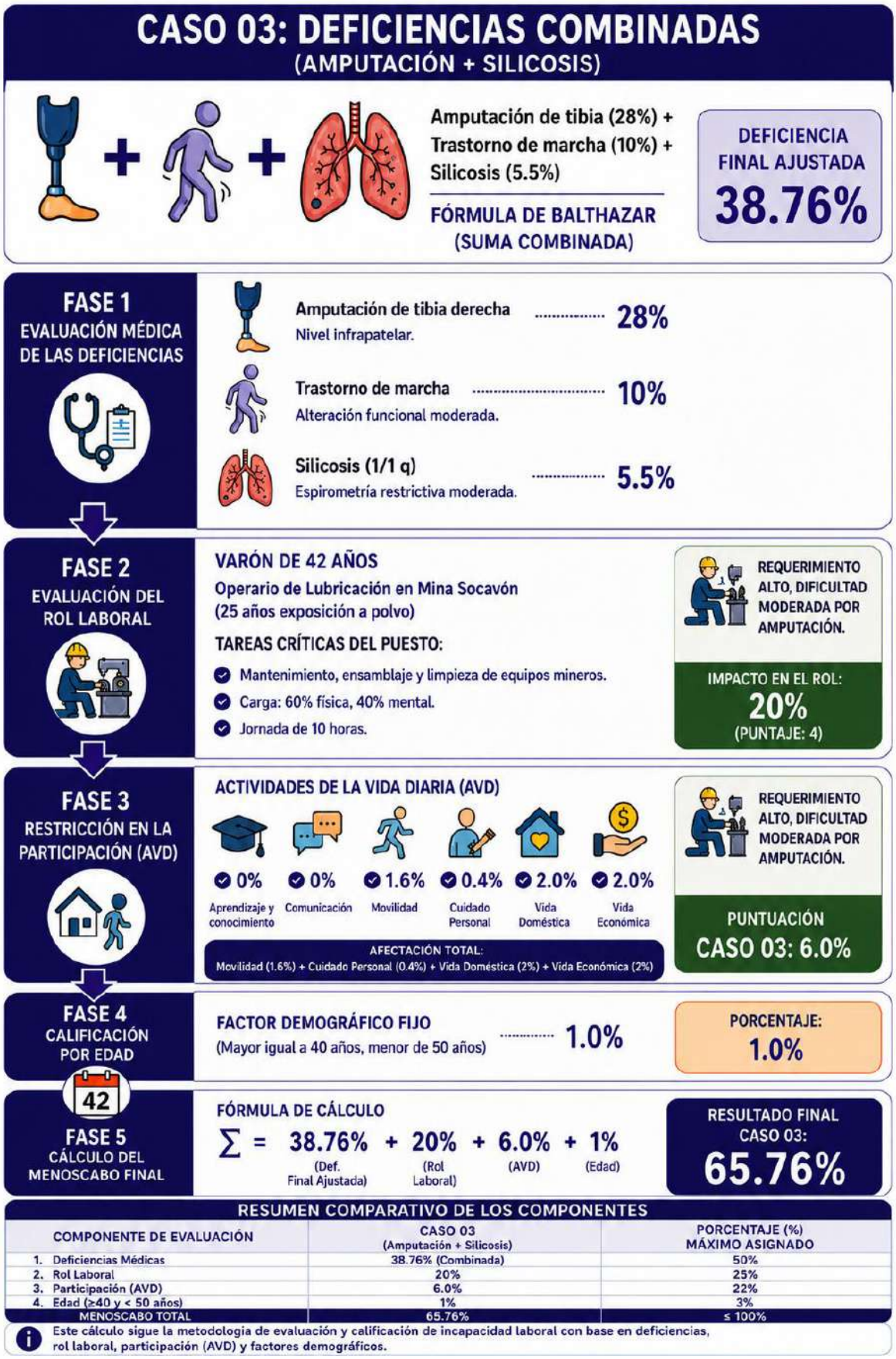
MENOSCABO TOTAL: **29.5%**

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE DE EVALUACIÓN	CASO 02 (Silicosis)	PORCENTAJE (%) MÁXIMO ASIGNADO
1. Deficiencias Médicas	5.5%	50%
2. Rol Laboral	20%	25%
3. Participación (AVD)	3.0%	22%
4. Edad (≥40 y <50 años)	1%	3%
MENOSCABO TOTAL	29.5%	≤ 100%

Este cálculo sigue la metodología de evaluación y calificación de incapacidad laboral con base en deficiencias, rol laboral, participación (AVD) y factores demográficos.

La imagen del caso es referencia.



La imagen del caso es referencial

6.5 De La Certificación Y Entrega Del Certificado De Incapacidad Laboral Por Accidente De Trabajo O Enfermedad Profesional

6.5.1 El Certificado de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional es emitido por las Comisiones-SCTR de acuerdo con el Anexo 9; será visado por el Director General del ES y remitido al trabajador asegurado y a la aseguradora que presentó la solicitud de certificación de la incapacidad laboral por AT o EP en el SCTR, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles posterior a la culminación del procedimiento. Adicionalmente, se le enviará a la aseguradora que presentó la solicitud de certificación de la incapacidad laboral por AT o EP en el SCTR, los exámenes realizados de forma física o digitalizado.

6.5.2 En el caso de rectificación y/o corrección del Certificado Médico de Incapacidad Laboral, se considera lo siguiente:

a) La Comisión-SCTR podrá corregir errores tipográficos, ortográficos, aritméticos u omisión en algún aspecto de la formalidad requerida en el certificado, que no modifiquen el fondo de la decisión, previa demostración de su fundamento.

b) Para efecto de lo dispuesto en el inciso a), la aseguradora que presentó la solicitud de certificación de la incapacidad laboral por AT o EP en el SCTR podrá presentar solicitudes de rectificación, aclaración y/o corrección del certificado emitido dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del certificado emitido.

c) La Comisión-SCTR podrá de oficio efectuar la actuación señalada en el inciso a) del presente numeral, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de emitido el certificado.

6.5.3 En caso de existir discrepancias entre la aseguradora del SCTR y el trabajador evaluado por el Certificado de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional emitido por la Comisión-SCTR, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de su notificación, la aseguradora o el asegurado a través de su aseguradora, podrán solicitar elevar el expediente al INR, para su pronunciamiento como instancia única administrativa, conforme a las materias y procedimiento establecido en el artículo 28 de las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por Decreto Supremo N° 003-98-SA y demás normas vigentes del SCTR.

6.6 Del Sistema de Registro de Información Para La Evaluación, Calificación y Certificación de la Incapacidad Laboral Por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional



Esta imagen es referencial



Esta imagen es referencial

Esta imagen es referencial

VII. RESPONSABILIDADES

7.1 NIVEL NACIONAL

El MINSA, a través del Viceministerio de Salud Pública y la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) o quien haga de sus veces es responsable de la difusión de la presente Norma Técnica de Salud hasta el nivel regional,

así como de brindar la asistencia técnica para la implementación, la supervisión y evaluación de su cumplimiento.

7.2 NIVEL REGIONAL

La DIRESA/GERESA/DIRIS es responsable de difundir la presente Norma Técnica de Salud en su respectivo ámbito o jurisdicción, así como de brindar asistencia técnica, implementarla y hacer cumplir lo establecido, monitorear, supervisar y evaluar su cumplimiento.

7.3 NIVEL LOCAL

Los titulares o responsables de la conducción o administración de las entidades públicas y privadas comprendidas en el ámbito de aplicación son responsables de aplicar, en lo que les corresponda, la presente Norma Técnica de Salud, bajo responsabilidad.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

8.1

Los ES evaluadores y los ES que conformen Comisiones-SCTR no deben tener dependencia económica o comercial con la aseguradora a la que el trabajador asegurado se encuentre afiliado, a fin de garantizar la imparcialidad de los procedimientos, cumpliendo con los protocolos y estándares técnicos y éticos correspondientes.

8.2

La metodología de evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral establecida en la presenta norma técnica de salud es aplicable para las nuevas solicitudes presentadas por los asegurados. Las solicitudes presentadas antes de la aprobación de la presente norma técnica de salud, los procesos dirimentes en trámite y las reevaluaciones serán evaluadas, calificadas y certificadas con la metodología vigente anterior a la aprobación de la presente norma técnica de salud.

8.3

A partir de la vigencia de la presente norma técnica de salud, las Comisiones Médicas Calificadoras de Incapacidad constituidas al amparo del Decreto Supremo N° 166 2005-EF se encuentran prohibidas de emitir certificados médicos, informes de evaluación médica y/o dictámenes médicos que contengan los diagnósticos señalados en el listado de enfermedades profesionales establecido en la Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA o la norma que la sustituya.

8.4

En caso el expediente descrito en el numeral 6.1 se encuentre incompleto porque la empresa empleadora haya fenecido, y con ello no se permita tener la documentación necesaria para el reconocimiento de la EP; la aseguradora del SCTR solicita que el CENSOPAS-INS, realice la evaluación pertinente para el reconocimiento de la EP, la evaluación de la deficiencia, del rol laboral y/o restricción en la participación en el marco de sus funciones y cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 6.2 según corresponda.

8.5

En un plazo de doscientos diez (210) días hábiles y bajo responsabilidad, las Gerencias Regionales de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y las Direcciones de Redes Integradas de Salud, mediante los ES ubicados en su jurisdicción deberán implementar los servicios de evaluación y conformar y establecer el funcionamiento de sus Comisiones-SCTR de acuerdo a los de los numerales 6.2, 6.3 y 6.4 de la presente Norma Técnica de Salud.

8.6

El MINSA elabora y aprueba en el plazo de 90 (noventa) días calendario el instrumento de evaluación y calificación de la incapacidad laboral (Manual Nacional de Evaluación y Calificación del Grado de Incapacidad) que debe contener como mínimo las siguientes unidades debidamente desarrolladas:

a) Unidad I Deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o cáncer.
b) Unidad II Deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular.
c) Unidad III Deficiencias por trastornos del sistema respiratorio.
d) Unidad IV Deficiencias del sistema digestivo.
e) Unidad V Deficiencias del sistema urinario y reproductor.
f) Unidad VI Deficiencias por trastornos de la piel, faneras y daño estético.
g) Unidad VII Deficiencias por alteraciones del sistema hematopoyético.
h) Unidad VIII Deficiencias por alteraciones del sistema endocrino.
i) Unidad IX Deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y vestibular.
j) Unidad X Deficiencias por alteraciones del olfato, del gusto, de la voz, del habla y de las vías aéreas superiores.
k) Unidad XI. Deficiencias por alteraciones del sistema visual.
l) Unidad XII Deficiencias del sistema nervioso central y periférico.
m) Unidad XIII. Deficiencias por trastornos mentales y del comportamiento.
n) Unidad XIV. Deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores.
o) Unidad XV. Deficiencias por alteración de la columna vertebral y pelvis.

8.7

En tanto el MINSA no apruebe el documento normativo que establezca el instrumento de evaluación y calificación de la incapacidad laboral, para la calificación de la deficiencia se emplea un instrumento que tenga criterios similares a los señalados en el numeral

anterior, y que se utilice en el sistema privado de administración de fondos de pensiones para tal efecto.

8.8

El MINSA a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública en coordinación con las regiones planificará un proceso de capacitación continua a los médicos evaluadores y miembros de las Comisiones-SCTR a fin de adquirir capacidades en el proceso de evaluación, calificación y certificación de la incapacidad laboral por AT o EP.

8.9

El INR deberá actualizar su procedimiento de evaluación y calificación de incapacidad laboral para el SCTR en Única Instancia Administrativa a ser aprobado con Resolución Directoral, previa comunicación a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.

IX. ANEXOS

Anexo 1: Documentos que integran el expediente que debe presentar la Aseguradora del SCTR al ES.

Anexo 2: Informe de Evaluación Médica de Incapacidad Laboral.

Anexo 3: Informe de Análisis del Puesto de Trabajo.

Anexo 4: Instructivo de Valoración de los Requerimientos del Puesto.

Anexo 5: Informe de Evaluación del Rol Laboral.

Anexo 6: Ficha de evaluación de la Restricción en la Participación.

Anexo 7: Calificación de la edad.

Anexo 8: Informe de Calificación del Rol Laboral y Restricción en la Participación.

Anexo 9: Certificado de Incapacidad Laboral por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

Anexo 10: Estándares para la toma de radiografías de Neumoconiosis-OIT.

ANEXO 1
Documentos que integran el expediente que debe presentar la Aseguradora del SCTR al ES.(*)

Documentos	Sí	No
ENFERMEDAD PROFESIONAL		
Perfil del puesto de trabajo del trabajador asegurado. (Requerimientos del Puesto de Trabajo y Capacidades del Trabajador)	☐	☐
Funciones principales y secundarias del puesto de trabajo.	☐	☐
Informe de la Historia de la Exposición Ocupacional en el/los puestos de trabajo donde se haya desempeñado el trabajador, que contenga: el tiempo de exposición por jornada y el tiempo de exposición en años, o exposición en caso de incidente, y las medidas de control según jerarquía de controles, firmado por el médico responsable de la vigilancia de la salud del trabajador de la Entidad Empleadora.	☐	☐
Monitoreos de factor de riesgo específico de los últimos años en el/los puestos de trabajo donde se haya desempeñado el trabajador: (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales) y medidas correctivas implementadas, según sea el caso, de acuerdo con la normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo.	☐	☐
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) de el/los puestos de trabajo donde se haya desempeñado el trabajador, de acuerdo a la normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo.	☐	☐
Exámenes médico-ocupacionales: preocupacionales, periódicos, de retiro, reincorporaciones laborales y/o reubicaciones laborales del trabajador asegurado.	☐	☐
Certificado Médico de diagnóstico de la enfermedad, y resultados de exámenes de apoyo diagnóstico si corresponde.	☐	☐
Informes médicos sobre atenciones por la contingencia laboral.	☐	☐
Informe de diagnóstico y reconocimiento de posible Enfermedad Profesional elaborado por el Médico Ocupacional del empleador y/o aseguradora.	☐	☐
Registros de Enfermedad Profesional.	☐	☐
Copia de Notificación en Sistema SAT de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.	☐	☐
ACCIDENTE DE TRABAJO		
Perfil del puesto de trabajo del trabajador asegurado. (Requerimientos del Puesto de Trabajo y Capacidades del Trabajador)	☐	☐
Funciones principales y secundarias del puesto de trabajo.	☐	☐
Registro del Accidente de trabajo.	☐	☐
Investigación del Accidente de Trabajo.	☐	☐
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) de el/los puestos de trabajo donde se haya desempeñado el trabajador, de acuerdo a la normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo.	☐	☐
Certificado Médico de diagnóstico del Accidente de Trabajo, y resultados de exámenes de apoyo diagnóstico si corresponde.	☐	☐
Informes médicos sobre atenciones por la contingencia laboral.	☐	☐
Copia de Notificación en Sistema SAT de Accidente de Trabajo.	☐	☐

(*) Los documentos debes ser entregados a la aseguradora de manera obligatoria por el empleador.

ANEXO 2

INFORME DE EVALUACIÓN MÉDICA DE INCAPACIDAD LABORAL

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN MÉDICA DE INCAPACIDAD LABORAL

Centro Asistencial (Hospital/Instituto)

Nº Expediente

Fecha | Día | Mes | Año

MINSA | EsSalud | EPS

Servicio

Especialidad

DATOS PERSONALES DEL EVALUADO

Apellido paterno | Apellido materno | Nombres

Nº DNI / Carnet de Extranjería | Sexo | Edad | Fecha de nacimiento

Grado de instrucción | Profesión | Experiencia laboral

Dirección actual
Calle/Jirón/Avenida | Block/Manzana/Urbanización

Distrito | Provincia | Departamento

INFORME MÉDICO

Antecedentes

Anamnesis

Examen Físico **(Resaltar signos resaltantes asociado a siniestro laboral)**

Resultados de exámenes de apoyo diagnóstico

Diagnósticos	CIE-10

Pronóstico (marcar)

Favorable	Recuperable	Irrecuperable	Malo

Naturaleza (Marcar)

Temporal	
Permanente	

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO

MÉDICO ESPECIALISTA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	**JEFE DE SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD**

Fuente: Adaptación de la Directiva Sanitaria N° 003-MINSA/DGSP.V01 Aplicación técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez-DS N° 166-2005-EF aprobado por R.M N° 478-2006-MINSA

ANEXO 3

INFORME DE ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

DATOS DE FILIACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Empresa:
Rubro de la empresa:
Nombre del puesto de trabajo:

Fecha:					Clasificador nacional de ocupaciones (CNO)
	1	2	3	4	

REQUERIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO Y CAPACIDADES DEL TRABAJADOR.

1. ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR

Tareas Principales	
Tareas Secundarias	
Uso de Maquinarias/Equipos o Herramientas	
Equipos de Protección Personal	

2. HORARIO DE TRABAJO

Horas diarias	Horario	Turno	Horas extras

3. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EXIGIDA

Actividades sin experiencia ni entrenamiento	
Actividades con experiencia básica, pero sin adiestramiento.	
Actividad con experiencia y que requiere un adiestramiento, entrenamiento o capacitación básicos	
Actividades con experiencia y con un grado de adiestramiento, entrenamiento o capacitación técnica que le permita desarrollar	

su actividad laboral manteniendo un rendimiento habitual	
Actividades con experiencia y con el adiestramiento, entrenamiento o capacitación universitaria necesarios. Se define como exigencia laboral intensa o "cualificada".	
Actividades con experiencia y especialmente adiestrada, entrenada o capacitación universitaria avanzado (postgrado). Se define como exigencia laboral especialmente intensa	

4. DIMENSIONES DE CARGA LABORAL

Física	
Mental	
Emocional	

5. NIVEL DE REQUERIMIENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Requerimiento	**Nivel**			
	Bajo	**Medio**	**Alto**	**Muy Alto**
Mental				
Memoria visual				
Semejanzas y diferencias				
Orientación espacial				
Conocimiento numérico				
Aprendizaje de tareas				
Lenguaje expresivo				
Conocimiento de la escritura				
Lenguaje comprensivo				
Conocimiento de la lectura				
Responsabilidad: autonomía laboral y realización de la tarea				
Repetitividad				
Atención				
Ritmo				
Organización				
Relaciones de trabajo				
Seguridad Física				

Manipulación Manual de carga,				
Coordinación manipulativa				
Carga postural/Trabajo repetitivo				
Trabajo de precisión				
Sedestación Mantenida				
Bipedestación				
Marcha por terreno irregular				
Campo visual				
Agudez visual				
Requerimiento Auditivo				
Requerimiento fonatorio				
Requerimiento de olfato y/o gusto				
Sensibilidad: superficial y/o profunda				
Emocional				
Control emocional				
Relaciones Psicosociales				
Otros				

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Adjuntar, si se considera necesario, análisis de tareas, procedimientos y descripción del puesto (fotos, planos, etc.).

ANEXO 4

INSTRUCTIVO DE VALORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

1. Carga Mental y Carga Emocional

Grado	% del tiempo de trabajo
1°	Menos de 20%
2°	20 a 40%
3°	Mayor a 40% y menos de 60%
4°	Mayor a 60%

2. Carga Física

2.1 Carga biomecánica por postura /repetitividad:

Grado	% del tiempo de trabajo
1°	Menos de 20%
2°	20 a 40%
3°	Mayor a 40% y menos de 60%
4°	Mayor a 60%

2.2 Manejo de cargas:

Grado	Tipo de Trabajo		% del tiempo de trabajo
	Varones	Mujeres	
1°	Menos de 3ª	Menos 3ª	Sin tiempo
2°	3ª a 15ª	3ª a 9ª	0 a 40%
3°	2 ª a 15ª 16ª a 25ª	3ª a 9ª 10ª a 15ª	Mayor a 40% 20ª
4°	16ª a 25ª Mayor a 25ª	10ª a 15ª Mayor a 15ª	Mayor a 20% Sin tiempo

2.3 Trabajo de precisión:

Grado	Tipo de Trabajo	% del tiempo de trabajo
1º	Sencilla	Tiempo
2º	Compleja-media	Menor a 40%
3º	Compleja-media	Mayor a 40%
4º	Compleja-elevada	Tiempo

2.4 Sedestación mantenida y Bipedestación:

Grado	% del tiempo de trabajo
1°	Menos de 20%
2°	20 a 40%
3°	Mayor a 40% y menos de 60%
4°	Mayor a 60%

2.5 Marcha por terreno irregular:

Grado	Tipo de Trabajo	% del tiempo de trabajo
1º	Llano con pequeños desniveles o escalones	Menos de 20%
2º	Llano con medianos desniveles o escalones	20 a 40%
3º	Llano con medianos desniveles o escalones o irregular con medianos is	Mayor a 40% menos de 60%
4º	Irregular con medianos niveles o escalones o Irregular con grandes desniveles o	Mayor a 60%

3. Requerimientos Visuales

3.1 Agudeza Visual

Grado	Tipo de Trabajo	Agudeza Binocular	
		Sistema Decimal	Sistema Inglés
1º	Trabajos de baja exigencia visual	Menos de 0.3	Menos de 20/70
2º	Trabajos de baja-mediana exigencia visual, incluidos trabajos en altura	0.3 a 0.4	20/70 a 20/50
3º	Trabajos de media-alta exigencia visual, incluidos trabajos en alturas	0.5 a 0.7	20/40 a 20/30
4º	Trabajos de muy altos requerimientos visuales, incluidos trabajos de precisión y aquellos sometidos a importantes riesgos (pilotos, bomberos)	0.8 a 1.0	20/25 a 20/20

3.2 Campo Visual

Grado	Tipo de Trabajo	Campo Visual
1º	Trabajos de baja exigencia visual	Menos de 20° centrales
2º	Trabajos de baja-mediana exigencia visual, incluidos trabajos en altura	20° a 30° centrales
3º	Trabajos de media-alta exigencia visual, incluidos trabajos en alturas	Mayor a 30° centrales
4º	Trabajos de muy altos requerimientos visuales, incluidos trabajos de precisión y aquellos sometidos a importantes riesgos (pilotos, bomberos)	Completo en ambos ojos

4. Requerimientos Auditivos

Grado	Tipo de Trabajo	UAM (dB)
1º	Trabajos de baja exigencia auditiva. No requieren mantener conversación. No requieren control de señales acústicas.	Mayor a 60
2º	Trabajos de mediana a baja exigencia auditiva. Requieren mantener una conversación en tonalidad normal.	50 – 60
3º	Trabajos de media-alta exigencia auditiva. Requieren mantener una conversación en voz baja o en ambientes ruidosos.	26 – 49
4º	Trabajos de muy altos requerimientos auditivos, incluidos músicos profesionales y aquellos sometidos a importantes riesgos (pilotos, bomberos, etc.)	Menos de 25

5.
Requerimientos fonatorios:

- Audibilidad: El trabajador debe tener la capacidad para hablar a un nivel suficiente como para ser oído. Se considera 25%e cuando debe mantenerse en lugares con ruido leve y la audición debe ser mantenida en el tiempo.

- Inteligibilidad: El trabajador debe mantener un porcentaje superior al 90% de las palabras identificables, de ser así se le da un valor del 25%.

- Eficiencia funcional: Será eficiente cuando se alcancen al menos 80-100 palabras por minuto. Si es así se le da un valor del 25%.

- Análisis perceptual con la escala GRBAS: la escala de Hirano se aplicará de la siguiente forma (G: grado global de conservación vocal. R: sin aspereza o pulsos glóticos B: voz aérea por glotis suficiente. A: fonación espontánea suficiente para el puesto. S: tensión vocal o impresión auditiva sin esfuerzo. Cada ítem se califica de 0-3 (0= normal; 1= leve; 2= moderado; 3= severo). La sumatoria de valores inferiores a 5 se consideran de baja exigencia. Si es de baja exigencia un valor del 25%.

Grado	Tipo de Trabajo	% de tiempo
1º	Baja exigencia fonatoria	Menos del 5%
2º	Trabajos de baja – media exigencia fonatoria. Requieren comunicación hablada.	5% a 49%
3º	Trabajos de mediana – alta exigencia fonatoria. Requieren el uso profesional de la voz.	50% a 80%
4º	Trabajos de alta exigencia fonatoria. Uso de voz profesional muy exigente.	Mayor a 80%

6. Requerimientos de olfato y/o gusto:

Grado	% de tiempo
1º	0 al 10%
2º	11 al 20%
3º	21 al 30%
4º	Mayor a 30%

7. Sensibilidad:
7.1 Superficial:

Grado	Tipo de Trabajo	% de tiempo
1°	Trabajos de baja exigencia sensorial superficial. No requiere empleo de la sensibilidad termo-algésica (o ausencia de riesgos termo-algésicos), y/o sensibilidad táctil. Ejemplos: personal directivo de empresas y comercios, analistas, etc.	Menos del 5%
2°	Trabajos de baja-media exigencia de la sensibilidad superficial termo-algésica y/o táctil; de su empleo poco frecuente; y aquellos sometidos a ligeros riesgos termoalgésicos. Ejemplos: vendedores de comercio, operadores de instalaciones y maquinania, etc.	5 a 49%
3°	Trabajos de media-alta exigencia de la sensibilidad superficial termo-algésica y/o táctil; de su empleo frecuente; y aquellos sometidos a moderados riesgos termoalgésicos. Ejemplos: enfermeros, cocineros, etc.	50 a 80%
4°	Trabajos de muy alta exigencia de la sensibilidad termoalgésica y/o táctil; de su empleo muy frecuente; y aquellos sometidos a importantes riesgos termoalgésicos. Ejemplos: atletas y deportistas, bomberos, etc.	Mayor a 80%

7.2 Profunda o propioceptiva:

Grado	Tipo de Trabajo	% de tiempo
1°	Trabajos de baja exigencia sensorial profunda. No requiere empleo de la sensibilidad profunda (barestésica, batiestésica, estereognósica), coordinación o estabilidad. Ejemplos: empleados de contabilidad, telefonistas, etc.	Menos del 5%
2°	Trabajos de baja-media exigencia de la sensibilidad profunda (barestésica, batiestésica, estereognósica), coordinación o estabilidad, o su requerimiento es poco frecuente. Ejemplos: técnicos de la educación, vendedores de comercio, etc.	5 a 49%
3°	Trabajos de media-alta exigencia de la sensibilidad profunda (barestésica, batiestésica, estereognósica), coordinación o estabilidad, o su requerimiento es frecuente. Ejemplos: artistas de artes plásticas y visuales; auxiliares de vuelo, etc.	50 a 80%
4°	Trabajos de muy alta exigencia de la sensibilidad (barestésica, batiestésica, estereognósica), coordinación o estabilidad, o de su requerimiento es muy frecuente. Ejemplos: pilotos de aviación, coreógrafos y bailarines, etc.	Mayor a 80%

ANEXO 5
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ROL LABORAL

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DE ROL LABORAL

Centro Asistencial (Hospital/Instituto)

Nº Expediente

Fecha

Día	Mes	Año

MINSA ☐ EsSalud ☐ EPS ☐

DATOS PERSONALES DEL EVALUADO

Apellido paterno	Apellido materno	Nombres

Nº DNI / Carnet de Extranjería	Sexo	Edad	Fecha de nacimiento

Grado de instrucción	Profesión	Tiempo laboral

Marcar con una "X" la categoría asignada

	NIVEL	PUNTAJE ASIGNADO
	Sin limitaciones en el puesto de trabajo original	0
	Limitaciones leves para la actividad laboral en el puesto de trabajo original	1
	Limitaciones moderadas para la actividad laboral en el puesto de trabajo original	2
	Con limitaciones severas para la actividad laboral del puesto de trabajo original	3
	Con limitaciones severas para la actividad laboral del puesto de trabajo original y limitaciones leves para actividades laborales de otro puesto de trabajo	4
	Sin posibilidad de realizar actividades laborales	5

a.

PUNATJE ASIGNADO	

MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA Y DEL MEDIO AMBIENTE

Fuente Adaptado de Ministerio de Trabajo, Manual Único para la Calificación de la Perdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, MINTRABAJO, Colombia: 2014.

Calificación de las Restricciones del Rol Laboral y Capacidades Laborales. Una vez identificado el puntaje de comparación de requerimientos y capacidades, se asignará el porcentaje adecuado según la siguiente tabla:

PUNTAJE	DEFINICIÓN	PORCENTAJE
0º	Sin limitaciones en el puesto de trabajo original	0
1º	Limitaciones leves para la actividad laboral en el puesto de trabajo original	5%
2º	Limitaciones moderadas para la actividad laboral en el puesto de trabajo original	10%
3º	Con limitaciones severas para la actividad laboral del puesto de trabajo original	15%
4º	Con limitaciones severas para la actividad laboral del puesto de trabajo original y limitaciones leves para actividades laborales de otro puesto de trabajo	20%
5º	Sin posibilidad de realizar actividades laborales	25%

ANEXO 6

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN- CIF

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DE LA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN - CIF

Centro Asistencial (Hospital/Instituto)

N° Expediente

Fecha: Día | Mes | Año

MINSA EsSalud EPS

DATOS PERSONALES DEL EVALUADO

Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres

N° DNI/ Carnet de Extranjería | Sexo | Edad | Fecha de nacimiento

Teniendo el cuenta el Instructivo de Clasificación del nivel de dependencia en la restricción en la participación, marque con una "X" la clase asignada

1	**Aprendizaje y aplicación del conocimiento (valor máximo posible 2.0)**	**CLASES**				
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
		0	**0.2**	**0.4**	**0.6**	**0.8**
1.1	Mirar: Usar el sentido de la vista intencionalmente para apreciar estímulos visuales, como ver un acontecimiento deportivo o niños jugando.					
1.2	Escuchar: Usar el sentido del oído para apreciar estímulos auditivos, como escuchar la radio, música o una lección.					
1.3	Pensar: Formular y manipular ideas, conceptos e imágenes, tanto orientadas como no a metas específicas, y que pueden ir acompañadas o no, como crear una ficción, probar un teorema, jugar con ideas, hacer una tormenta de ideas, meditar, valorar o ponderar, especular o reflexionar					
1.4	Resolver problemas y tomar decisiones: Encontrar soluciones a problemas y situaciones detectando y analizando las consecuencias, desarrollando opciones y soluciones, evaluando efectos potenciales de las soluciones y ejecutando la solución escogida, como resolver una disputa entre dos personas					
1.5	Llevar a cabo tareas simples: Llevar a cabo, acciones sencillas o complejas y coordinadas relacionadas con los componentes mentales y físicos implicados en una tarea, como iniciar una tarea, organizar el tiempo, espacio y materiales para una realizar una tarea, llevarla a cabo, completarla y mantener la actividad.					
2	**Comunicación (valor máximo posible 4.0)**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	**0**	**0.2**	**0.4**	**0.6**	**0.8**
2.1	Comunicarse con recepción de mensajes verbales					
2.2	Comunicarse con---recepción de---mensajes escritos: Comprender el significado literal e implícito de mensajes que están estructurados a través del lenguaje escrito (incluido Braille), como seguir eventos políticos en el periódico o entender el mensaje de una escritura religiosa o de una historia.					
2.3	Habla: Producir palabras, frases y párrafos en mensajes hablados con significado literal e implícito, como la habilidad de expresar un hecho o contar una historia en lenguaje oral.					

2.4	Mensajes escritos: La habilidad de producir mensajes con significado literal o implícito, expresados mediante el lenguaje escrito, como escribir una carta a un amigo.					
2.5	Conversación: Iniciar, sostener y finalizar un intercambio de pensamientos e ideas, llevado a cabo a través de lenguaje hablado, escrito, de signos u otras formas de lenguaje, con una o más personas conocidas o extraños, en un ambiente formal o informal.					
3	**Movilidad (valor máximo posible 4.0)**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	**0**	**0.2**	**0.4**	**0.6**	**0.8**
3.1	Mantener la posición del cuerpo: Mantener el cuerpo en la misma posición durante el tiempo necesario, como permanecer sentado o permanecer de pie en el trabajo o colegio.					
3.2	Levantar y llevar objetos: Levantar un objeto y llevarlo de un sitio a otro, como levantar una taza o llevar a un niño de una habitación a otra.					
3.3	Uso fino de la mano: Realizar acciones coordinadas relacionadas con manejar, recoger, manipular y soltar objetos, utilizando una mano, los dedos y el pulgar (los dedos de la mano), como levantar monedas de una mesa, o girar un tirador/perilla/picaporte.					
3.4	Uso de la mano y el brazo: Realizar las acciones coordinadas que se requieren para manipular y mover objetos utilizando las manos y los brazos, como girar tiradores/perillas/picaportes o lanzar o coger un objeto					
3.5	Andar y desplazarse por el entorno: Avanzar sobre una superficie a pie, paso a paso, de manera que al menos un pie esté siempre en el suelo, como caminar hacia delante, hacia atrás o de lado.					
4	**Cuidado Personal (valor máximo posible 4.0)**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	**0**	**0.2**	**0.4**	**0.6**	**0.8**
4.1	Lavarse: Lavarse y secarse todo el cuerpo o partes del cuerpo, utilizando agua y materiales o métodos apropiados de lavado y secado, como bañarse ducharse, lavarse las manos y la cara, el pelo; y secarse con una toalla					
4.2	Higiene personal relacionada con los procesos de excreción: Planificación y ejecución de la eliminación de residuos humanos (menstruación, orinar y defecar) y la propia limpieza posterior					
4.3	Vestirse: Llevar a cabo las acciones coordinadas relacionadas con ponerse y quitarse ropa y calzado en el orden correcto y de acuerdo con las condiciones climáticas, como poner, colocar y quitar, camisas, faldas, blusas, pantalones, ropa interior, medias, sombreros, guantes, abrigos, zapatos, botas, sandalias y zapatillas/pantuflas.					
4.4	Comer y beber: Llevar a cabo las tareas y acciones coordinadas relacionadas con comer y beber la comida o bebida que está servida, llevarla a la boca y consumirla de una manera culturalmente aceptable, en un contexto/entorno uniforme, cortar o partir la comida en pequeños trozos, abrir botellas y latas, usar cubiertos.					
4.5	Cuidado de la propia salud: Asegurar la salud y bienestar físico y mental, en un contexto/entorno uniforme, como mantener una dieta balanceada/equilibrada, un nivel adecuado de actividad física, una temperatura corporal adecuada, prevenir daños para la salud, seguir prácticas sexuales seguras, incluyendo el uso de preservativos, seguir los planes de inmunización y realizar exámenes físicos regulares.					
5	**Vida Doméstica (valor máximo posible (4.0)**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	**0**	**0.2**	**0.4**	**0.6**	**0.8**
5.1	Adquisición de un lugar para vivir: Comprar, alquilar, amueblar y organizar una casa, apartamento u otra vivienda					
5.2	Adquisición de bienes y servicios: Seleccionar, obtener y transportar todos los bienes y servicios necesarios para la vida diaria, como seleccionar, obtener, transportar y almacenar comida, bebida, ropa, productos de limpieza, combustible, artículos para la casa, utensilios, baterías de cocina, aparatos domésticos y herramientas; procurarse servicios y utilidades domésticas					

5.3	Realizar los quehaceres de la casa: Ocuparse de la casa limpiándola, lavando la ropa, usando aparatos domésticos, almacenando comida y eliminando la basura, como barrer, pasar el trapeador, limpiar las encimeras, paredes y otras superficies; recoger y eliminar la basura de la casa; ordenar habitaciones, armarios y cajones; recoger, lavar, secar, doblar y planchar ropa; limpiar calzado; utilizar escobas, cepillos y aspiradoras; utilizar lavadoras, secadoras y planchas					
5.4	Cuidado de los objetos del hogar: Mantener y reparar los objetos del hogar y otros objetos personales, incluyendo la casa y su contenido, la ropa, los vehículos y los dispositivos de ayuda y el cuidado de plantas y animales, como pintar o empapelar las habitaciones, reparar los muebles, reparar las cañerías, asegurarse de que los vehículos funcionan adecuadamente, regar las plantas, cuidar y alimentar mascotas y animales domésticos.					
5.5	Ayudar a los demás: Ayudar a miembros de la casa y a otras personas en su aprendizaje, en la comunicación, en el auto cuidado o en el desplazamiento dentro o fuera de la casa; preocuparse por el "bienestar" de los miembros de la casa y de otras personas					

6.0	**Autosuficiencia económica (valor máximo posible (2.0)** **Nivel de gravedad, excluyentes entre los tres indicadores** **Consignar una sola situación**	**Porcentaje**	**Situación del evaluado**
6.1	. **Autosuficiencia económica completa:** Evaluado ejerce un rol laboral que le permite generar los mismos ingresos económicos antes de adquirir las secuelas del accidente de trabajo o enfermedad profesional.	**0%**	
6.2	**Autosuficiencia económica recortada:** Evaluado ejerce el mismo rol laboral o un rol laboral diferente al habitual que le genera reducción de ingresos económicos antes de adquirir las secuelas del accidente de trabajo o enfermedad profesional .	**1%**	
6.3	**Sin Autosuficiencia económica**: Evaluado no ejerce un rol laboral debido a la secuela del accidente o enfermedad profesional, lo que le impide generar ingresos económicos. .	**2%**	

MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION

Fuente Adaptado de Ministerio de Trabajo, Manual Único para la Calificación de la Perdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, MINTRABAJO, Colombia: 2014.

Instructivo de Clasificación del nivel de dependencia en la restricción en la participación

CLASE	CRITERIO CUALITATIVO	Criterios para su asignación considerando la(s) deficiencia(s) evaluada(s)
A	No hay dificultad – no dependencia	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para: iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento; del cuidado personal; de la movilidad; en la ejecución de las tareas y demandas generales; de la comunicación y de la vida económica y doméstica. No requiere de ayudas. Es independiente. **NO DEPENDENCIA.**
B	Dificultad leve – no dependencia	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento; del cuidado personal; de la movilidad; en la ejecución de las tareas y demandas generales; de la comunicación y de la vida económica y doméstica, requiere de mayor tiempo; no requiere de ayudas. Es independiente. **NO DEPENDENCIA.**
C	Dificultad moderada – dependencia moderada	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento; del cuidado personal; de la movilidad; en la ejecución de las tareas y demandas generales; de la comunicación y de la vida económica y doméstica, requiere del uso de ayudas técnicas para la ejecución de estas. **DEPENDENCIA MODERADA.**
D	Dificultad severa – dependencia severa	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento; del cuidado personal; de la movilidad; en la ejecución de las tareas y demandas generales; de la comunicación y de la vida económica y doméstica, requiere ayuda de otras personas para el desarrollo de la actividad. La persona presenta una **DEPENDENCIA SEVERA.**
E	Dificultad completa – dependencia grave/completa	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento; del cuidado personal; de la movilidad; en la ejecución de las tareas y demandas generales; de la comunicación y de la vida económica y doméstica requiere ayudas técnicas y/o ayuda personal; no realiza las actividades por sí solo. **DEPENDENCIA GRAVE-COMPLETA**

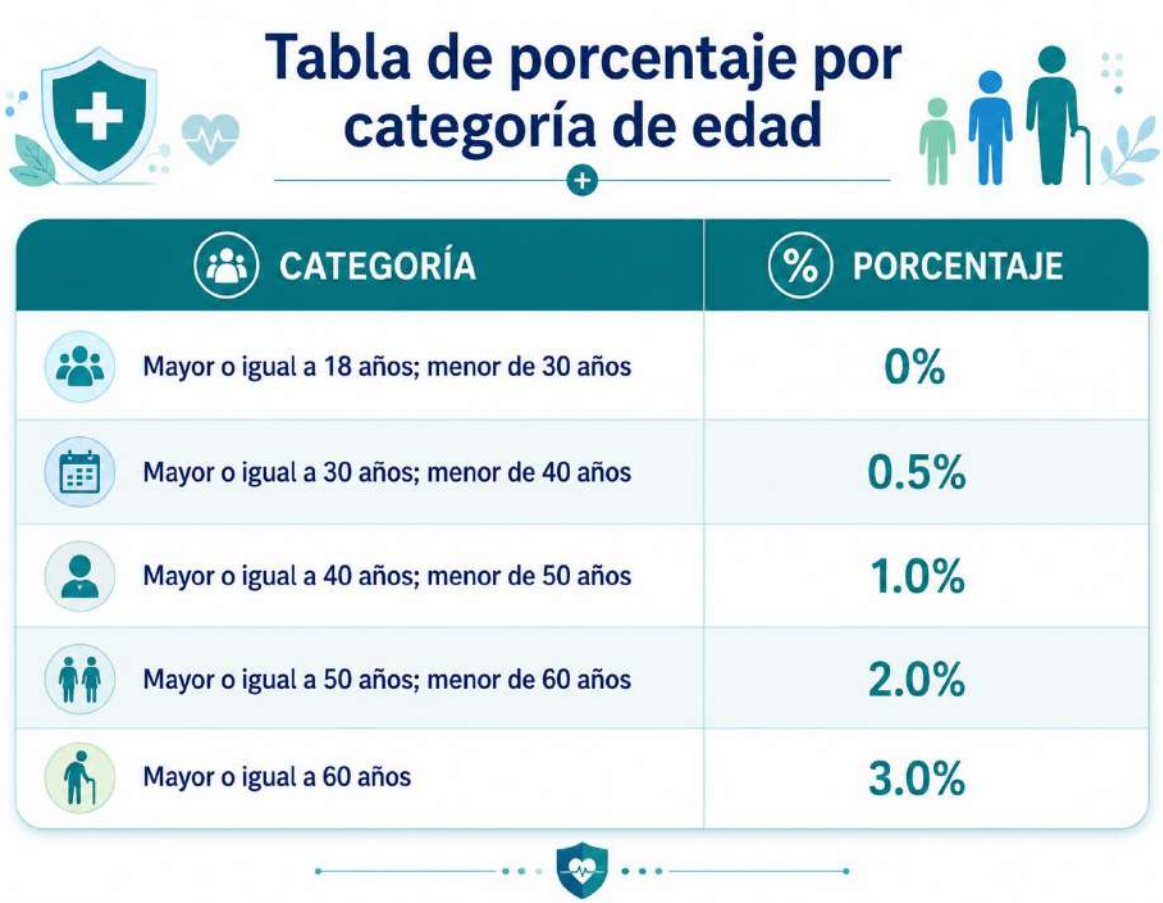
PARA LA CALIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDADES PROFESIONALES SE CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS SOBRE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE FUNCIONAMIENTO (CIF).

SITUACIONES VITALES Y PORCENTAJE MÁXIMO ASIGNADO

SITUACIONES VITALES	PORCENTAJE MÁXIMO ASIGNADO
Aprendizaje y aplicación del conocimiento	4%
Comunicación	4%
Movilidad	4%
Cuidado Personal	4%
Vida doméstica	4%
Vida económica	2%
PUNTAJE TOTAL	22%

ANEXO 7

CALIFICACIÓN DE LA EDAD



ANEXO 8
INFORME DE CALIFICACIÓN DEL ROL LABORAL Y RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACION DEL ROL LABORAL Y RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

Centro Asistencial (Hospital/Instituto)

Nº Expediente

Fecha | Día | Mes | Año

MINSA ☐ EsSalud ☐ EPS ☐

DATOS PERSONALES DEL EVALUADO

Apellido paterno | Apellido materno | Nombres

Nº DNI / Carnet de Extranjería | Sexo | Edad | Fecha de nacimiento

Grado de instrucción | Profesión | Tiempo laboral

Dirección actual

Calle/Jirón/Avenida | Block/Manzana/Urbanización

Distrito | Provincia | Departamento

DATOS LABORALES DEL EVALUADO

Entidad Empleadora *(Razón Social)* | RUC | CIIU

Dirección *(principal)* | Teléfono | Correo electrónico

Aseguradora de SCTR *(Razón social)* | Teléfono | Correo electrónico

Puesto de trabajo | Tiempo puesto *(meses)* | Tiempo de experiencia *(meses)*

Tipo de contrato | Fecha de ingreso

SINIESTRO LABORAL

☐ Accidente de Trabajo

Fecha de Accidente | Naturaleza de lesión | Parte del cuerpo afectado

CIE-10	Diagnóstico

Enfermedad Ocupacional

Fecha de diagnóstico	Causa	Lugar de diagnóstico

CIE-10	Diagnóstico

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL
Evaluación de las Capacidades y Requerimientos del Puesto de Trabajo

Calificación del rol laboral

Calificación de la restricción en la participación-CIF

Calificación de la Edad

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO

MÉDICO OCUPACIONAL – Comisión-SCTR

ANEXO 9
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Nº de Certificado

Centro Asistencial (Hospital/Instituto)

Fecha

Día	Mes	Año

Nº de Expediente

MINSA

EsSalud

EPS

DATOS PERSONALES DEL EVALUADO

Apellido paterno	Apellido materno	Nombres

Nº DNI / Carnet de Extranjería	Sexo	Edad	Fecha de nacimiento

Estado civil	Grado de instrucción	Profesión

Teléfono	Correo electrónico

Dirección Actual

Calle/Jirón/Avenida	Block/Manzana/Urbanización

Distrito	Provincia	Departamento

SINIESTRO LABORAL

Accidente de Trabajo

Enfermedad Ocupacional

Fecha de accidente

Fecha de diagnóstico

La Comisión Calificadora de Incapacidad por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, de acuerdo con sus facultades certifica lo siguiente:

a. Diagnósticos

	CIE-10

b. Incapacidad

Grado

	Parcial		Total		Gran Incapacidad

Naturaleza

d. Menoscabo

	Temporal		Permanente	%

I. Porcentaje de Deficiencia	
II. Valoración Rol laboral y restricción en la Participación	
MENOSCABO DE LA CAPACIDAD LABORAL	

Fecha de inicio de incapacidad

Día	Mes	Año	No se precisa

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO

PRESIDENTE DEL COMISIÓN-SCTR	**MIEMBRO DEL COMISIÓN-SCTR**	**MIEMBRO DEL COMISIÓN-SCTR**

MIEMBRO DE LA COMISIÓN-SCTRTR	OM **MIEMBRO DE LA COMISIÓN-SCTRTR**

Fuente: Adaptación de la Directiva Sanitaria N° 003-MINSA/DGSP.V01 Aplicación técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez-DS N° 166-2005-EF aprobado por R.M N° 478-2006-MINSA

ANEXO 10

ESTÁNDARES PARA LA TOMA DE RADIOGRAFIAS DE NEUMOCONIOSIS OIT

Equipo

Convencional

- Equipo de rayos x fijo con generador no menor de 300 mA a 125 KV con fuente de poder eléctrico independiente, con tubo de ánodo rotatorio, con spot focal menor a 2mm de diámetro, con filtración total equivalente de 0,7 mmAL y colimación de haz de radiación.
- Parrilla o buky Vertical, Grilla de 10:1 y 100 líneas por pulgada.
- Barrera emplomada de protección para el operador.
- Mandil emplomado.
- Chasis con pantalla intensificadora de velocidad media sensible al verde de 14x14 y 14x17 pulgadas (35x35 y 35x43cm).
- Procesadora automática de películas radiográficas.
- Negatoscopio de 3 cuerpos con luminosidad entre 50 – 100 lux.
- Infraestructura adecuada con licencia del IPEN para el trabajo con radiaciones ionizantes en el diagnóstico médico.

Digital

- Los sistemas radiográficos para adquirir, visualizar y almacenar imágenes de tórax para la clasificación de neumoconiosis deben cumplir con las versiones más recientes de los estándares DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) u otros estándares comparables (por ejemplo, MEDICOM EN 12052). Los estándares DICOM (http://medical.nema.org) son ampliamente aceptados y usados internacionalmente para imágenes radiográficas. Especifican un formato común para el almacenamiento y transferencia de imágenes digitales y para los niveles de brillo y contraste, además de una consistente escala de grises para cuando se presenten las imágenes en monitores de visualización o se impriman las imágenes digitales. Se debe tener mucho cuidado en conservar la calidad y la consistencia de la imagen al producir las copias físicas de las imágenes digitales.
- Equipos para imágenes aceptados para el uso de la Clasificación de la OIT, con la debida atención a la calidad de la imagen:
    - ✓ El hardware con sistemas basados en la tecnología de almacenamiento de fósforo se describe como una radiografía computarizada (CR).
    - ✓ Sistemas, conocido como radiografías digitales (DR), se encuentran disponibles recientemente

Técnica

- El centrado correcto del tubo radiográfico y la cuidadosa posición del paciente son de gran importancia para la adecuada visualización de las estructuras anatómicas y para la comparación de exámenes seriados, para la incidencia PA, el tubo radiográfico debe centrarse en el centro de la película y el rayo dirigido horizontalmente. Los hombres deben colocarse de tal manera que las escápulas queden fuera de los campos pulmonares. La exposición debe efectuarse en inspiración completa, e inmediatamente después de haber alcanzado ésta, para evitar el efecto de Valsalva. Es deseable pero no esencial sacar todas las ropas por encima de la cintura.
- La distancia tubo-placa debe fijares en 1,8 m. y no debe ser menor de 1,5 m. Por estas razones, se recomienda una técnica con alto kilovoltaje variable y miliampere-seg. constante.
- Los factores de exposición pueden variar algo con cada generador y tubo. Se emplear el m s alto rango de kilovoltaje y el m s bajo rango de miliampere-seg. Obtenible. Para el sujeto promedio, con un di metro torácico A-P entre 21 y 23 cm. los factores de exposición ser n comúnmente 5mAs y aproximadamente 125 kV. El tiempo de exposición recomendado es 1/60 seg. (0,017) no excediendo 1/30 (0,03) seg.(basado en corriente de 60 Hz). Para corriente de 50 Hz, los tiempos de exposición son 1/50 (0,02) y 1/25 (0,04) seg. respectivamente.
- Con diámetros torácicos mayores, la exposición adicional se obtiene aumentando el kilovoltaje. El producto miliampere-seg, se aumentar únicamente cuando el kilovoltaje requerido para dar una exposición adecuada exceda la capacidad del generador o del tubo de rayos. Con distancias tubo-placa menores de 1,8 m. se ajustar la técnica disminuyendo el factor miliampere-seg. Cuando se emplean técnicas con m s bajo kilovoltaje, los factores de exposición para un sujeto promedio ser n aproximadamente de 300 hA, 0,05 seg. (15 mAs) y 75 kV. Para sujetos mayores se obtiene una mayor radiación, o bien aumentando el producto miliampere segundo o bien el kilovoltaje.
- Se reconoce, sin embargo que el problema de la técnica radiográfica óptima permanece aún controvertido entre expertos internacionales. Criterios físicos sobre la calidad técnica en Radiografías de tórax.
    - A. Densidad óptica 1. Las regiones hiliares deben exhibir un mínimo de 0,2 unidades de densidad óptica por encima del velado. 2. Las regiones de parénquima deben exhibir un máximo de 1,8 unidades de densidad óptica por encima del velado.
    - B. Contraste de gran imagen: (diferencia de densidad óptica entre el segmento más oscuro de parénquima pulmonar y las porciones más claras de las regiones hiliares). Debe caer en el rango entre 1,0 y 1,4 unidades de densidad óptica.
    - C. Potenciales de los tubos de rayos y uso de parrilla. 1. Potenciales de 70 a 100 kV; emplear parrillas para todos los sujetos cuya dimensión A-P exceda 22 cm.; 2. Potenciales mayores de 100 kV: usar parrillas para todos los sujetos.
    - D. Tiempo de exposición no mayor de 0,1 seg. y preferentemente 0,05 seg. o menos.
    - E. Combinación película-pantalla: Usar películas de mediana velocidad y pantallas para asegurar un adecuado detalle de la imagen. Un buen contacto pantalla-película es esencial así como un control periódico.
    - F. Procesamiento: Mantener la fuerza y temperatura de los procesadores químicos dentro de los límites recomendados por el fabricante.
    - G. Supuestos Se mantiene la limpieza de las películas, las pantallas, los líquidos de procesamiento y el equipo.
    - H. Se tiene cuidado en la posición adecuada del paciente.
    - I. Se evita el movimiento del paciente.

X. BIBLIOGRAFÍA

1) Naciones Unidas - Comisión Económica para América Latina (CEPAL); Bietti, María; Personas con discapacidad e inclusión laboral en América Latina y el Caribe Principales desafíos de los sistemas de protección social. 2023. . 2023. Disponible en internet: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1535653e-6f21-456e-bb5a-dc446ff5c8ad/content
2) Organización Internacional del Trabajo. Estrategia y plan de acción para la inclusión de la discapacidad 2014-2017. Ginebra. Disponible en internet: https://www.ilo.org/es/media/50286/download.
3) Decreto 1507/2014, de 12 de agosto. Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional Decreto 1507. Ministerio de Trabajo. Colombia. 2014. Disponible en internet: https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/manuales/ManualUnicoCalificaciones_2014.pdf
4) Acuerdo No. 0305-2018 Manual: Calificación de la Discapacidad. Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Normatización, Dirección Nacional de Discapacidades- Ecuador. 2018. Disponible en internet: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/12/Manual_Calificaci%C3%B3n-de_Discapacidad_2018.pdf
5) Manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Fundación Descúbreme. Chile. 2021. Disponible en internet: https://www.descubreme.cl/wp-content/uploads/2021/05/Manual-de-Buenas-Practicas-de-Inclusion-Laboral.pdf
6) Resolución Ministerial 0756 del 22 de diciembre del 2022. Manual de Proceso y Procedimientos para la Calificación, registro y Carnetización de discapacidad. Ministerio de Salud y Deportes. Estado Plurinacional de Bolivia. 2022. Disponible en internet: https://www.minsalud.gob.bo/6420-normas-y-manuales-ministerio-de-salud-y-deportes?start=2.
7) Estrategia Española Sobre Discapacidad 2022-2030; para el acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Aprobada por Consejo de Ministros. España.2022. Disponible en internet: . https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/estrategia-espanola-discapacidad-2022-2030-def.pdf
8) Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. España. 2022. Disponible en internet: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17105.pdf
9) Teófila V-HM, Jesús T-GM, M. C-GL, de la Torre María Victoria R-Í, Encarna A-J, José A-BM, et al. Discapacidad e incapacidad laboral en España. Actualización legislativa 2016 [Internet]. Redalyc.org. Disponible en internet: https://www.redalyc.org/journal/4577/457754052017/457754052017.pdf
10) García Herrera M. Las guías de valoración de los requerimientos laborales en la Incapacidad Laboral: la Guía de Valoración Profesional del INSS, el

mercal y la Guía Mejorada del Instituto de Biomecánica de Valencia. Med Segur Trab (Madr) [Internet]. 2014. Disponible en internet: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0465-546X2014000500014

11) Tordoya J, Jimmy E. Guía metodológica para elaborar el diagnóstico fisioterapéutico según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), de la discapacidad y de la salud. Gac médica boliv [Internet]. 2016 Disponible en internet: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662016000100011

12) Cañón L, Rafael J. Calificación y valoración de la enfermedad profesional: análisis de la situación actual y propuestas de mejora. Med Segur Trab (Madr) [Internet]. 2016;62:87–95. Disponible en internet: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2016000400009

13) Vicente Pardo, José M. La valoración de la profesión, del trabajo, de la ocupación, y de las tareas en el procedimiento de valoración de la capacidad laboral en materia de seguridad social. Rev. Medicina y Seguridad del Trabajo (Internet) 2014; 60 (237) 660-674. Octubre - diciembre 2014. Disponible en internet: https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v60n237/inspeccion1.pdf

14) Gordillo E, Marcone P, Ritter P, Veas J. Reflexión sobre la equidad del sistema de calificación médica para invalidez en Chile. Rev Med Chil [Internet]. 2021;149(6):906–12. Disponible en internet: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872021000600906

15) Delgado-Carrillo, Mercedes J.; Chávez-Prado, Jorge E.; Sancan-Moreira, Mercy T. Importancia de la evaluación clínica en la discapacidad. Dom. Cien., ISSN: 2477-8818 Vol. 5, núm. 3, pp. 71-87. Julio 2019.

16) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Clasificador Nacional de Ocupaciones 2015. Basado en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 elaborado por la Organización Internacional del Trabajo. Estadísticas. 2012. En Disponible en internet: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4123438/Clasificador%20Nacional%20de%20Ocupaciones%202015.pdf?v=1676476271

17) Instituto de Seguridad Social, Manual de Evaluación de Requerimientos para la Valoración de la Capacidad Laboral (MERCAL-2008). España.

18) Organización Mundial de la Salud, Clasificacion Internacional del Funcionamiento , de la Discapacidad y de la Salud-CIF, OMS: 2001.



Av. Salaverry 801, Jesús María - Lima - Perú
Central: (01) 315 6600
www.gob.pe/minsa

@Minsa_Peru /minsaperu @minsaperu @minsa_peru